



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PELAYANAN
INSTALASI LABORATORIUM**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN

Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium

Disusun oleh:

Kepala Instalasi BDRS



(dr. Brilliant Margalin, Sp.PK., MARS)

Disetujui oleh:

Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP)

Ditetapkan oleh:

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(Heni Indra Wulandari, S. Kep., Ns., M.Kep)

TIM PENYUSUN

PENGARAH

1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP

PENYUSUN

1. dr. Brilliant Margalin, Sp.PK., MARS
2. Elza Safarina Ulfa, AMd.AK
3. Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep
4. Suparmi, Amd.AK
5. Aulya Wahyuningrum Rena Dumillah, Amd.Kes
6. Tersa Donara Wulan, Amd.Kes
7. Hesty Putri Wulandari, S.Tr.Kes
8. Nikmatul Khoiria, Amd.Kes
9. Irma Novitasari, Amd.Kes
10. Yesy Fitri Eka Firdaus, Amd.Kes
11. Ekananta Pratiwi, Amd.Kes
12. Anita Suprihatinigrum, Amd.Kes
13. Tansah Sinawang Sakinah, S.Tr.Kes
14. Gusti Naila Rachmawati Gufron, S.Tr.Kes

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi sasaran keselamatan pasien, standar pelayanan berfokus pasien, standar manajemen rumah sakit, program nasional dan Integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan di rumah sakit.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Pasuruan, 01 Desember 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Heni Indra Wulandari, S. Kep., Ns., M.Kep

DAFTAR ISI

SAMPULi

LEMBAR PENGESAHAN.....ii

TIM PENYUSUNiii

KATA PENGANTAR.....iv

DAFTAR ISIv

DAFTAR TABELvi

PERATURAN DIREKTURviii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang1

 1.2 Maksud dan Tujuan2

 1.3 Ruang Lingkup2

 1.4 Batasan Operasional3

BAB II STANDAR KETENAGAAN4

 2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia4

 2.2 Distribusi Ketemnagaan.....16

 2.3 Pengaturan Jaga17

BAB III STANDAR FASILITAS.....18

 3.1 Denah Ruang18

 3.2 Standar Fasilitas.....20

BAB IV KEMAMPUAN PELAYANAN22

BAB V TATA LAKSANA PELAYANAN.....25

 5.1 Pengelolaan Spesimen.....25

 5.2 Kerangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan33

 5.3 Nilai Kritis Laboratorium.....35

 5.4 Kerjasama Laboratorium Rujukan39

BAB VI LOGISTIK.....41

 6.1 Perencanaan Kebutuhan41

 6.2 Pengadaan41

 6.3 Penerimaan42

 6.4 Penyimpanan43

 6.5 Distribusi44

 6.6 Penggunaan44

 6.7 Pengendalian Persediaan.....44

 6.8 Pemantauan Masa Berlaku45

 6.9 Kekosongan Reagen46

BAB VII KESELAMATAN PASIEN48

 7.1 Keselamatan Pasien Tahap Pra Analitik.....48

 7.2 Keselamatan Pasien Tahap Analitik48

 7.3 Keselamatan Pasien Tahap Pasca Analitik.....49

BAB VIII KESELAMATAN KERJA.....50

 8.1 Identifikasi dan Bahaya Kerja50

 8.2 Penggunaan Alat Pelindung Diri50

 8.3 Keselamatan Biologis (*Biosafety*)51

 8.4 Keselamatan Kimia.....51

 8.5 Keselamatan Peralatan dan Listrik51

 8.6 Keselamatan Kebakaran52

 8.7 Penanganan Tumpahan52

 8.8 Penanganan Paparan dan Kecelakaan Kerja.....52

BAB IX PENGENDALIAN MUTU53

 9.1 Pemantapan Mutu Internal (PMI).....53

	9.2 Pemantapan Mutu Eksternal (PME).....	53
	9.3 Pelaporan dan Penanganan Ketidaksesuaian	53
BAB X	PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia 4

Tabel 2.2.1 distribusi ketenagaan16

Tabel 2.3.1 peraturan jaga17

Tabel 3.1 persyaratan minimal bangunan sarana prasarana laboratorium klinik Madya ..18

Tabel 3.2 Peralatan minimal laboratorium20

Tabel 3.3 Perlengkapan Keselamatan Dan Keamanan Laboratorium21

Tabel 4.1 Kemampuan Pelayanan Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo .23

Tabel 5.1.1 Pemeriksaan berdasarkan Metode dan Jenis Reagen 30

Tabel 5.2.1 Kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan33

Tabel 5.3.1 Nilai Kritis Laboratorium.....35

Tabel 5.3.2 Rentang Nilai Normal Laboratorium36

Tabel 6.2.1 Syarat Pengadaan Barang.....42

Tabel 8.2.1 APD Wajib Petugas Laboratorium50

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 951.5/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025**

**TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM**

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan laboratorium merupakan salah satu pelayanan penunjang medis yang berperan penting dalam mendukung penegakan diagnosis, pemantauan terapi, penentuan prognosis, serta pengambilan keputusan klinis dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
 - b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelayanan laboratorium yang bermutu, aman, efektif, efisien, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan yang menjadi acuan bagi seluruh petugas di Instalasi Laboratorium;
 - c. bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 522/RSPHS/I-PER/DIR/III/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik;
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik ATLM;
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Tranfusi Darah;
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
 - 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klarifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
 - 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam medis;
 - 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;

11. Kepdirjen Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02./D/43961/2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
12. Kepdirjen Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
13. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor :1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

- (1) Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
- (2) Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dna pemulihan kesehatan;
- (3) Laboratorium Patologi Klinik merupakan laboratorium yang melakukan pemeriksaan terhadap berbagai specimen baik berupa darah, feses, cairan tubuh (urine, cairan sendi, cairan pleura, liquor cerebrospinal, cairan ascites , dan lain-lain) sumsum tulang guna menunjang diagnose pemeriksaan;
- (4) Laboratorium Patologi Anatomi merupakan pelayanan diagnostic dan laboratorium terhadap jaringan atau cairan tubuh. Pelayanan ini berperan sebagai penunjang dalam penegakan diagnosis yang berbasis perubahan morfologi sel dan jaringan sampai pemeriksaan imunologik dan molekuler;
- (5) Spesimen klinik adlaah bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan/atau analisis lainnya, termasuk *new-emeging* dan *re-emeging*, dan penyakit infeksi berpotensi pandemik.

BAB II STANDAR KETENAGAAN

Pasal 2 Kualifikasi Sumber Daya Manusia

- (1) Instalasi Laboratorium Rumah Sakit wajib memiliki sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan pendidikan, kompetensi,

- kredensial, kewenangan, dan perizinan sesuai dengan jenis pelayanan laboratorium yang diselenggarakan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sumber daya manusia Instalasi Laboratorium terdiri atas:
 - a. Dokter Spesialis Patologi Klinis ;
 - b. Dokter Patologi Anatomi;
 - c. Tenaga Teknologi Laboratorium Medik (ATLM);
 - (3) Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Patologi Anatomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (4) Tenaga Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) wajib:
 - a. Memiliki ijazah pendidikan yang diakui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku;
 - c. Memiliki Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Memiliki kompetensi yang sesuai dengan pelayanan dan peralatan laboratorium yang dioperasikan;
 - (5) Direktur rumah sakit menetapkan penanggung jawab laboratorium yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan perundang – undangan;
 - (6) Setiap tenaga laboratorium memiliki uraian tugas, kewenangan, tanggung jawab, dan penugasan klinis yang terdokumentasi sesuai dengan kompetensi dan ruang lingkup pekerjaannya;
 - (7) Rumah sakit melakukan proses kredensial bagi tenaga laboratorium sebelum diberikan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan serta melakukan rekredensial secara berkala sesuai kebijakan rumah sakit;
 - (8) Staf laboratorium yang membuat interpretasi memenuhi persyaratan kredensial;
 - (9) Staf laboratorium lain yang melaksanakan pemeriksaan termasuk yang mengerjakan *Point-of-Care Testing* (POCT) memenuhi persyaratan kredensial.

Pasal 3 Distribusi Ketenagaan

- (1) Kepala Instalasi Laboratorium bertanggung jawab melakukan perencanaan, penempatan, dan pemerataan tenaga laboratorium sesuai dengan kompetensi, kewenangan klinis, dan kebutuhan pelayanan pada setiap unit atau area kerja laboratorium;
- (2) Penempatan tenaga laboratorium harus memperhatikan kesesuaian antara kompetensi petugas dengan jenis pemeriksaan, teknologi, peralatan, dan tingkat risiko pekerjaan yang dilaksanakan;
- (3) Distribusi tenaga laboratorium harus menjamin tersedianya petugas yang kompeten pada setiap tahapan pelayanan laboratorium yang meliputi:

- a. Tahap pra-analitik;
- b. Tahap analitik;
- c. Tahap pasca-analitik.

Pasal 4
Pengaturan Jaga

- (1) Jadwal jaga dan dinas tenaga laboratorium disusun oleh Kepala Instalasi Laboratorium berdasarkan kebutuhan pelayanan, jumlah dan kompetensi tenaga, beban kerja, serta jam operasional pelayanan laboratorium;
- (2) Setiap shift pelayanan laboratorium wajib didukung oleh jumlah tenaga yang memadai sesuai dengan volume pemeriksaan, kompleksitas pelayanan, dan tingkat risiko pelayanan;
- (3) Pengaturan jaga dan dinas memperhatikan ketentuan jam kerja, waktu istirahat, keselamatan dan kesehatan kerja, pencegahan kelelahan kerja, serta ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku;
- (4) Serah terima tugas antar shift dilakukan secara terdokumentasi untuk menjamin kesinambungan pelayanan, keamanan spesimen, keakuratan hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut terhadap pemeriksaan yang masih berlangsung;
- (5) Jadwal jaga dan dinas wajib dievaluasi secara berkala berdasarkan kebutuhan pelayanan, hasil analisis beban kerja, indikator mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta hasil evaluasi kinerja tenaga laboratorium.

BAB III
STANDAR FASILITAS

Pasal 5
Standar Peralatan

- (1) Instalasi Laboratorium Rumah Sakit menyediakan peralatan laboratorium yang memadai, aman, berfungsi dengan baik, dan sesuai dengan jenis serta kompleksitas pelayanan yang diselenggarakan;
- (2) Peralatan laboratorium memenuhi standar mutu, persyaratan teknis, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Setiap peralatan laboratorium memiliki identitas, spesifikasi teknis, petunjuk penggunaan, dan dokumentasi yang lengkap;
- (4) Peralatan laboratorium hanya boleh dioperasikan oleh petugas yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) Instalasi Laboratorium memiliki program pemeliharaan, kalibrasi, verifikasi, validasi, dan uji fungsi peralatan sesuai rekomendasi pabrikan dan ketentuan yang berlaku;
- (6) Seluruh kegiatan pemeliharaan, kalibrasi, perbaikan, dan penggantian peralatan harus didokumentasikan dan disimpan sebagai rekaman mutu laboratorium;
- (7) Peralatan yang mengalami kerusakan, tidak memenuhi standar kinerja, atau berpotensi membahayakan keselamatan pasien

dan petugas harus segera ditarik dari penggunaan dan diberikan penandaan yang jelas.

Pasal 6
Standar Bangunan

- (1) Bangunan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit dirancang, dibangun, dipelihara, dan dikembangkan sesuai dengan fungsi pelayanan, kebutuhan operasional, keselamatan pasien, keselamatan kerja, pengendalian infeksi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bangunan Instalasi Laboratorium memiliki lokasi yang mudah diakses oleh pasien, petugas, dan unit pelayanan terkait serta mendukung kelancaran alur pelayanan rumah sakit;
- (3) Tata ruang laboratorium harus dirancang untuk menjamin kelancaran alur kerja, mencegah kontaminasi silang, serta memisahkan area pelayanan sesuai dengan fungsi dan tingkat risiko masing-masing;
- (4) Bangunan laboratorium harus memiliki sistem pencahayaan, ventilasi, suhu ruangan, kelembaban, sanitasi, dan utilitas yang memadai sesuai persyaratan teknis laboratorium kesehatan;
- (5) Bangunan laboratorium wajib dilengkapi dengan sarana keselamatan dan keamanan, termasuk jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, sistem peringatan darurat, fasilitas cuci tangan, dan sarana pengelolaan limbah.

BAB IV
KEMAMPUAN PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Instalasi Laboratorium menyelenggarakan pelayanan laboratorium sebagai pelayanan penunjang medis untuk mendukung upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pendidikan, penelitian, serta peningkatan mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan kemampuan dan klasifikasi rumah sakit;
- (2) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan patologi klinik yang diselenggarakan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk mendukung pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan penunjang lainnya;
- (3) Kemampuan pelayanan laboratorium sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Pelayanan hematologi;
 - b. Pelayanan kimia klinik;
 - c. Pelayanan imunologi dan serologi;
 - d. Pelayanan urinalisis;
 - e. Pelayanan pemeriksaan feses;
 - f. Pelayanan mikrobiologi dasar;
 - g. Pelayanan pemeriksaan laboratorium cito untuk mendukung pelayanan kegawatdaruratan.
 - h. Pelayanan patologi anatomi

BAB V
TATA LAKSANA PELAYANAN

Pasal 8
Pengelolaan Spesimen

- (1) Pengelolaan spesimen dilaksanakan sesuai:
 - a. Permintaan pemeriksaan;
 - b. Pengambilan, pengumpulan, dan identifikasi spesimen;
 - c. Pengiriman, pembuangan, penyimpanan dan pengawetan;
 - d. Penerimaan, penyimpanan, telusur spesimen (*tracking*);
- (2) Pemeriksaan Laboratorium
- (3) Pencatatan dan pelaporan hasil
- (4) Dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan spesimen.

Pasal 9
Kerangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan

- (1) Rumah sakit menetapkan dan menerapkan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium reguler dan cito;
- (2) Dilakukan pencatatan dan evaluasi waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium reguler, cito, dan rujukan:
 - a. Pemeriksaan Cito waktu pemeriksaan $\pm$ 30 Menit;
 - b. Pemeriksaan Reguler waktu pemeriksaan $\pm$ 60 Menit.

Pasal 10
Nilai Kritis

- (1) Rumah sakit menetapkan dan mengevaluasi rentang nilai normal untuk interpretasi, pelaporan hasil laboratorium klinis;
- (2) Setiap pemeriksaan laboratorium dilengkapi dengan rentang nilai normal.

Pasal 11
Kerjasama Laboratorium Rujukan

- (1) Rumah Sakit dapat melakukan kerja sama dengan laboratorium rujukan untuk pemeriksaan laboratorium yang belum dapat dilaksanakan oleh Instalasi Laboratorium Rumah Sakit karena keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, reagen, metode pemeriksaan, atau alasan teknis lainnya;
- (2) Kerja sama dengan laboratorium rujukan harus dilakukan secara tertulis melalui perjanjian kerja sama yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan rumah sakit;
- (3) Unit laboratorium memiliki bukti sertifikat akreditasi laboratorium rujukan yang masih berlaku;
- (4) Dilakukan pemantauan dan evaluasi kerjasama pelayanan kontrak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB VI LOGISTIK

Pasal 12

- (1) Instalasi Laboratorium Rumah Sakit menyelenggarakan pengelolaan logistik secara efektif, efisien, aman, dan terdokumentasi untuk menjamin kesinambungan pelayanan laboratorium serta mutu hasil pemeriksaan;
- (2) Logistik laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi reagen, bahan kontrol, bahan kalibrator, bahan habis pakai, media pemeriksaan, bahan kimia, peralatan penunjang, dan kebutuhan operasional laboratorium lainnya;
- (3) Pengelolaan logistik laboratorium meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, penggunaan, pengendalian persediaan, pemantauan masa berlaku, serta penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Instalasi Laboratorium menerapkan sistem pengendalian persediaan dengan metode *First Expired First Out* (FEFO) dan/atau *First In First Out* (FIFO) untuk mencegah penggunaan bahan yang kedaluwarsa atau tidak layak pakai;
- (5) Distribusi logistik laboratorium menjamin ketepatan jenis, jumlah, mutu, dan waktu penyediaan logistik sesuai kebutuhan pelayanan.

BAB VII KESELAMATAN PASIEN

Pasal 13

- (1) Instalasi Laboratorium Rumah Sakit menerapkan program keselamatan pasien pada seluruh tahapan pelayanan laboratorium untuk mengurangi risiko terjadinya kesalahan, kejadian tidak diharapkan, dan dampak yang dapat membahayakan pasien;
- (2) Penerapan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada seluruh proses pelayanan laboratorium;
- (3) Setiap kejadian Insiden Keselamatan Pasien wajib dilaporkan, dianalisis, ditindaklanjuti, dan digunakan sebagai bahan perbaikan mutu secara berkelanjutan;
- (4) Instalasi Laboratorium wajib berpartisipasi dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit melalui kegiatan identifikasi risiko, pelaporan insiden keselamatan pasien, analisis akar masalah, serta implementasi tindakan perbaikan dan pencegahan.

BAB VIII KESELAMATAN KERJA

Pasal 14

- (1) Instalasi Laboratorium Rumah Sakit wajib menerapkan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk melindungi pasien, petugas, pengunjung, serta lingkungan rumah sakit dari risiko bahaya yang timbul akibat penyelenggaraan pelayanan laboratorium;
- (2) Program K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui identifikasi, penilaian, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi risiko terhadap seluruh aktivitas pelayanan laboratorium;
- (3) Setiap petugas laboratorium mematuhi kebijakan, prosedur, dan standar keselamatan kerja yang berlaku serta menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan jenis pekerjaan dan tingkat risiko yang dihadapi;
- (4) Instalasi Laboratorium wajib menyediakan alat pelindung diri yang memadai, sekurang-kurangnya berupa jas laboratorium, sarung tangan, masker, pelindung wajah, pelindung mata, dan alat pelindung lainnya sesuai kebutuhan pelayanan;
- (5) Petugas laboratorium menerapkan prinsip kewaspadaan standar (*standard precautions*), praktik kerja yang aman, serta tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi dalam setiap kegiatan pelayanan laboratorium;
- (6) Instalasi Laboratorium wajib melakukan pengelolaan bahan infeksius, bahan kimia berbahaya, bahan biologis, benda tajam, dan limbah laboratorium sesuai dengan ketentuan keselamatan kerja, keselamatan biologis (*biosafety*), dan keamanan biologis (*biosecurity*);
- (7) Setiap kecelakaan kerja, paparan bahan infeksius, tertusuk jarum, tumpahan bahan berbahaya, kebakaran, atau insiden keselamatan kerja lainnya wajib dilaporkan, didokumentasikan, dianalisis, dan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BAB IX PENGENDALIAN MUTU

Pasal 15

- (1) Instalasi Laboratorium melaksanakan Pemantapan Mutu Internal (PMI) secara rutin sesuai jenis pemeriksaan yang dilakukan untuk memantau dan memastikan kinerja pemeriksaan laboratorium;
- (2) Instalasi Laboratorium mengikuti Pemantapan Mutu Eksternal (PME) atau uji profesiensi yang diselenggarakan oleh institusi yang berwenang sesuai dengan ruang lingkup pelayanan laboratorium;
- (3) Hasil kegiatan Pemantapan Mutu Internal dan Pemantapan Mutu

Eksternal wajib dianalisis, didokumentasikan, ditindaklanjuti, dan digunakan sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan laboratorium;

- (4) Instalasi Laboratorium menetapkan indikator mutu pelayanan laboratorium yang meliputi indikator pada tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- (5) Setiap ketidaksesuaian, penyimpangan hasil pemeriksaan, kejadian tidak diharapkan, atau insiden yang berpotensi memengaruhi mutu pelayanan wajib dilaporkan, dianalisis, dilakukan tindakan korektif dan preventif, serta didokumentasikan.

BAB X PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 529/RSPHS/I-PER/DIR/III/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 1 Desember 2025
Direktur RS Prima Husada



Ns.Heni Indra Wulansari,S.Kep.,M.Kep

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR: 951.5/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI
LABORATORIUM

PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Pelayanan laboratorium merupakan salah satu komponen penunjang medis yang memiliki peran strategis dalam proses diagnosis, penatalaksanaan terapi, pemantauan kondisi pasien, serta penentuan prognosis. Kualitas hasil pemeriksaan laboratorium sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan klinis oleh tenaga medis, sehingga diperlukan sistem manajemen mutu yang terstandar, efektif, dan berkesinambungan.

Perkembangan teknologi laboratorium serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap mutu layanan kesehatan menuntut Instalasi Laboratorium Rumah Sakit untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan standar akreditasi rumah sakit maupun ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang laboratorium, penyelenggaraan pelayanan rumah sakit, serta keselamatan pasien. Kedua regulasi tersebut menekankan pentingnya penerapan mutu pelayanan, pengendalian risiko, pemastian kompetensi sumber daya manusia, kalibrasi alat, serta kepatuhan terhadap prosedur operasional baku.

Selain itu, laboratorium memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya kesalahan proses, mulai dari fase pra-analitik, analitik, hingga pasca-analitik, yang dapat berdampak langsung pada keselamatan pasien. Kesalahan tersebut dapat berupa kesalahan pengambilan spesimen, ketidaktepatan identifikasi pasien, kontaminasi sampel, ketidaksesuaian prosedur analitik, maupun keterlambatan pelaporan hasil. Oleh karena itu, penerapan Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) harus menjadi prioritas dalam setiap tahapan pelayanan laboratorium, termasuk identifikasi pasien yang benar, komunikasi efektif, peningkatan keamanan penggunaan bahan berbahaya, serta pencegahan dan pengendalian infeksi.

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pelayanan laboratorium yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien, diperlukan penyusunan Program Kerja Instalasi Laboratorium yang terencana, terukur, dan berkesinambungan. Program kerja ini disusun sebagai panduan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu, pengendalian risiko, pengembangan sumber daya manusia, optimalisasi sarana prasarana, serta monitoring dan evaluasi sesuai standar akreditasi dan regulasi pemerintah. Dengan demikian, diharapkan pelayanan laboratorium dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap mutu pelayanan rumah sakit secara keseluruhan dan meningkatkan keselamatan serta kepuasan pasien.

1.2 Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Instalasi Laboratorium disusun sebagai pedoman operasional dan arah pengembangan pelayanan laboratorium rumah sakit dalam satu periode kerja. Dokumen ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan laboratorium berjalan secara terencana, terukur, efektif, efisien, serta sejalan dengan standar akreditasi, regulasi pemerintah, dan kebutuhan pelayanan klinis rumah sakit. Program kerja ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, pengendalian mutu, peningkatan kompetensi, manajemen risiko, serta optimalisasi pelayanan laboratorium secara berkesinambungan.

2. Tujuan Umum

Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan laboratorium rumah sakit yang bermutu tinggi, aman, akurat, cepat, berorientasi pada keselamatan pasien, serta mampu mendukung proses diagnosis, terapi, dan pemantauan kondisi pasien sesuai standar akreditasi dan peraturan perundang-undangan.

3. Tujuan Khusus

- a. Menjamin terselenggaranya pelayanan laboratorium yang memenuhi standar mutu, keselamatan pasien, dan kesinambungan pelayanan.
- b. Memastikan seluruh proses pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik berjalan sesuai SOP, standar akreditasi, dan Permenkes.
- c. Mengurangi potensi medical error melalui penguatan identifikasi pasien, komunikasi efektif, dan pengendalian risiko.
- d. Memastikan seluruh peralatan laboratorium dikalibrasi dan diverifikasi sesuai jadwal dan standar.
- e. Meningkatkan kompetensi tenaga laboratorium melalui pelatihan, workshop, penilaian kompetensi, dan sertifikasi sesuai bidangnya.
- f. Menjamin pemenuhan jumlah dan kualifikasi SDM sesuai standar pelayanan laboratorium klinik.
- g. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana laboratorium untuk menjamin kesinambungan pelayanan.
- h. Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko laboratorium (biologis, kimia, radiasi, dan alat).
- i. Memastikan kepatuhan terhadap standar K3 laboratorium, pengelolaan B3, dan penanganan limbah sesuai regulasi.
- j. Mengoptimalkan manajemen persediaan reagen, bahan habis pakai, dan alat laboratorium secara efisien dan akurat.
- k. Mengembangkan sistem pelaporan, pencatatan, dan evaluasi yang efektif dan mudah diakses.
- l. Meningkatkan kepuasan pasien dan pengguna layanan melalui inovasi pelayanan dan perbaikan berkelanjutan.

1.3 Ruang Lingkup Pelayanan

Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo melayani seluruh pasien dalam 24 jam selama 7 hari kerja. Sesuai dengan PMK 411 tahun 2010 tentang Laboratorium. Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo (Rumah Sakit Tipe C) adalah laboratorium Madya yang melayani pemeriksaan :

- (1) Hematologi,
- (2) Kimia klinik, sebagian
- (3) Mikrobiologi klinik

-
- (4) Parasitologi klinik
 - (5) Imunologi klinik.
 - (6) Cairan Tubuh
 - (7) Elektrolit
 - (8) Blood gas analitik
 - (9) Patologi anatomi
 - (10) Pelayanan darah (BDRS)

1.4 Batasan Operasional

- a. Laboratorium terintegrasi adalah laboratorium yang dapat digunakan untuk melayani semua jenis pemeriksaan seperti patologi klinik, patologi anatomi dan mikrobiologi yang terintegrasi dalam satu lokasi dengan tujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi laboratorium ke arah yang lebih efisien, strategis, terpadu, dan kolaboratif. Organisasi pelayanan laboratorium yg dibentuk dan diselenggarakan sesuai peraturan perundangan di rumah sakit dapat terbentuk pelayanan laboratorium terintegrasi yang membawahi semua jenis pelayanan laboratorium di rumah sakit.
- b. Laboratorium Klinik adalah Laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
- c. Spesimen klinik adalah Bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan/atau analisis lainnya, termasuk new-emerging dan re-emerging dan penyakit infeksi berpotensi pandemik.
- d. Pemeriksaan teknik otomatis adalah pemeriksaan laboratorium menggunakan alat automatic yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku mulai dari tahap melakukan pengukuran sampel sampai dengan pembacaan hasil.
- e. Seluruh pasien laboratorium Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yang di maksud adalah:
 - IGD (Instalasi Gawat Darurat)
 - Pasien Rawat Jalan
 - Pasien Rawat Inap
 - IKO (Instalasi Kamar Operasi)
 - MCU (Medical Check Up)

BAB II
STANDAR KETENAGAAN

2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia
1. Kualifikasi dan Kompetensi

Tabel 2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia

No	Jabatan	Kualifikasi	Kompetensi
1	Kepala Instalasi Laboratorium	a. Dokter Spesialis Patologi Klinik (Sp.PK) atau Dokter Spesialis Patologi Anatomi (Sp.PA) b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku. c. Memiliki Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan yang berlaku. d. Memiliki kewenangan klinis (<i>clinical privilege</i>) yang ditetapkan oleh rumah sakit.	a. Pengelolaan operasional b. Supervisi SDM c. Mutu d. Logistik e. K3 dan PPI
2	Dokter Spesialis Patologi Klinik	a. Dokter yang telah menyelesaikan pendidikan spesialis Patologi Klinik/Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium. b. Memiliki STR Spesialis Patologi Klinik yang masih berlaku. c. Memiliki SIP sesuai tempat praktik. d. Memiliki kewenangan klinis (<i>clinical privilege</i>) yang ditetapkan melalui proses kredensial rumah sakit.	a. Kompetensi Profesional (<i>Clinical Competency</i>) b. Kompetensi Diagnostik Laboratorium c. Kompetensi Manajemen Laboratorium
3	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	a. Lulusan pendidikan dokter yang telah menyelesaikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Patologi Anatomi pada institusi pendidikan yang diakui pemerintah. b. Memiliki ijazah dokter spesialis Patologi Anatomi (Sp.PA). c. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dokter spesialis yang masih berlaku.	a. Melakukan pemeriksaan histopatologi. b. Melakukan pemeriksaan sitopatologi. c. Melakukan interpretasi dan validasi hasil pemeriksaan patologi anatomi. d. Melakukan pemeriksaan frozen section. e. Melakukan

		d. Memiliki Surat Izin Praktik (SIP) sesuai lokasi praktik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Telah melalui proses kredensial dan memperoleh kewenangan klinis (clinical privilege) yang ditetapkan oleh rumah sakit.	pemeriksaan FNAB dan interpretasinya. f. Melakukan pemeriksaan imunohistokimia sesuai kompetensi dan fasilitas rumah sakit. g. Menandatangani laporan hasil pemeriksaan patologi anatomi. h. Memberikan konsultasi diagnostik kepada dokter penanggung jawab pasien
4	Kepala Ruang Laboratorium	a. Pendidikan minimal Diploma III Teknologi Laboratorium Medis (D-III TLM), diutamakan Diploma IV atau Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. b. Memiliki STR ATLM yang masih berlaku. c. Memiliki Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan (SIPTK) atau ketentuan lain sesuai regulasi yang berlaku. d. Memiliki pengalaman kerja di laboratorium minimal 3 tahun	a. Pengelolaan operasional b. Supervisi SDM c. Mutu d. Logistik e. K3 dan PPI
5	Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	a. Pendidikan minimal Diploma III Teknologi Laboratorium Medis (D-III TLM). b. Dapat berasal dari lulusan: • D-III Teknologi Laboratorium Medis. • D-IV Teknologi Laboratorium Medis. • Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. c. Memiliki STR ATLM yang masih berlaku.	a. Kompetensi pra analitik b. Kompetensi analitik c. Kompetensi pasca analitik d. Pengendalian mutu dan keselamatan pasien

		d. Memiliki izin praktik sesuai ketentuan yang berlaku.	
--	--	---	--

2. Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

a. Kepala Instalasi Laboratorium

1) Uraian Tugas

a) Melaksanakan fungsi perencanaan

- (1) Menyusun rencana kerja, program dan anggaran Instalasi Laboratorium terkait SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, Pendidikan dan Pelatihan Staf, Mutu, keselamatan pasien dan keselamatan kerja di Instalasi Laboratorium.
- (2) Menyusun perencanaan kebutuhan staf berdasarkan pola ketenagaan dan pengembangan pelayanan
- (3) Menyusun jadwal dinas staf sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kebutuhan pasien.
- (4) Menyusun program orientasi staf di Instalasi Laboratorium

b) Melaksanakan fungsi pergerakan

- (1) Mengatur dan mengkondisikan seluruh kegiatan pelayanan Laboratorium kolaborasi dengan kepala bidang dan kepala unit lain.
- (2) Melaksanakan orientasi kepada staf baru.
- (3) Membimbing staf di Instalasi Laboratorium untuk melaksanakan asuhan pelayanan pasien sesuai standar.
- (4) Memberikan laporan berkala tentang pelayanan asuhan pasien di Instalasi Laboratorium.
- (5) Melaksanakan pengaturan penempatan dan penempatan kembali staf berdasarkan kompetensi, kebutuhan atau kekurangan staf dan pertimbangan nilai – nilai, kepercayaan dan agama staf.
- (6) Mendelegasikan tugas kepada setiap stafnya

c) Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian

- (1) Mengendalikan dan menilai pelaksanaan pelayanan pasien yang telah ditentukan.
- (2) Melakukan penilaian kinerja dan mutu staf di Instalasi Laboratorium yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- (3) Melakukan supervisi staf di Instalasi Laboratorium terkait dengan kewenangan klinisnya.
- (4) Melakukan evaluasi perencanaan kebutuhan staf berdasarkan kebutuhan

2) Tanggung Jawab

- a) Kebenaran dan ketepatan perencanaan kebutuhan staf di Instalasinya.
- b) Kebenaran dan ketepatan pengembangan pelayanan di Instalasinya
- c) Kebenaran dan ketepatan pelaporan nilai kritis pasien kepada DPJP.
- d) Keobjektifan dan kebenaran penilaian kinerja staf di unitnya.
- e) Kelancaran kegiatan pelayanan di Instalasi Laboratorium.
- f) Kebenaran dan ketepatan protap SPO pelayanan
- g) Pemeliharaan sarana dan prasarana di Instalasinya

3) Wewenang

- a) Meminta informasi dan pengarahan kepada atasan.
- b) Memberi petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas staf di Instalasinya
- c) Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan staf, peralatan dan mutu pelayanan di Instalasi Laboratorium.
- d) Menandatangani surat dan dokumen yang menjadi wewenang kepala ruangan.
- e) Menghadiri rapat dan pertemuan berkala

b. Kepala Ruang Laboratorium

1) Uraian Tugas

a) Pengelolaan pelayanan laboratorium

- (1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan laboratorium pada tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik sesuai standar profesi ATLM.
- (2) Memastikan pelayanan laboratorium berjalan sesuai kebijakan, pedoman, dan SPO rumah sakit.
- (3) Mengawasi pelaksanaan pelayanan laboratorium rutin, cito, dan pelayanan 24 jam apabila tersedia.
- (4) Memastikan ketepatan identifikasi pasien dan spesimen.
- (5) Mengawasi pelaksanaan pemeriksaan Point of Care Testing (POCT).

b) Pengelolaan sumber daya manusia

- (1) Menyusun jadwal dinas dan pembagian tugas petugas laboratorium.
- (2) Melaksanakan orientasi pegawai baru.
- (3) Melakukan supervisi, pembinaan, dan penilaian kinerja staf laboratorium.
- (4) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi staf.
- (5) Memastikan petugas bekerja sesuai kredensial dan kewenangan klinis yang dimiliki

- c) Pengelolaan Mutu Laboratorium
 - (1) Mengkoordinasikan pelaksanaan Pemantapan Mutu Internal (PMI).
 - (2) Mengkoordinasikan pelaksanaan Pemantapan Mutu Eksternal (PME).
 - (3) Melakukan monitoring indikator mutu laboratorium.
 - (4) Menindaklanjuti hasil audit internal dan eksternal.
 - (5) Melaksanakan program peningkatan mutu berkelanjutan
- d) Pengelolaan sarana, prasarana, dan logistik
 - (1) Mengawasi pemeliharaan, kalibrasi, dan uji fungsi alat laboratorium.
 - (2) Mengawasi penyimpanan dan penggunaan reagen serta bahan habis pakai.
 - (3) Memastikan ketersediaan logistik laboratorium.
 - (4) Mengusulkan kebutuhan alat dan reagen kepada manajemen rumah sakit.
- e) Pengelolaan keselamatan dan manajemen risiko
 - (1) Mengawasi pelaksanaan program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).
 - (2) Mengawasi penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium.
 - (3) Melaksanakan identifikasi dan mitigasi risiko pelayanan laboratorium.
 - (4) Mengawasi pengelolaan limbah medis dan B3.
 - (5) Menindaklanjuti insiden keselamatan pasien dan insiden keselamatan kerja.
- f) Administrasi dan pelaporan
 - (1) Menyusun laporan harian, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.
 - (2) Mengelola dokumen mutu, pedoman, kebijakan, dan SPO laboratorium.
 - (3) Menyiapkan data dan dokumen untuk akreditasi rumah sakit.
 - (4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan laboratorium secara berkala

2) Tanggung Jawab

- a) Bertanggung jawab atas kelancaran operasional pelayanan laboratorium.
- b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan laboratorium sesuai standar profesi dan SPO.
- c) Bertanggung jawab atas mutu pemeriksaan laboratorium melalui pelaksanaan PMI dan PME.
- d) Bertanggung jawab atas ketepatan proses pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik.
- e) Bertanggung jawab atas pengawasan administrasi dan dokumentasi laboratorium.
- f) Bertanggung jawab atas pelaksanaan program mutu laboratorium.

- g) Bertanggung jawab atas pelaksanaan program PPI dan K3 laboratorium.
- h) Bertanggung jawab atas pemeliharaan alat laboratorium dan pengelolaan reagen.
- i) Bertanggung jawab atas pembinaan, supervisi, dan evaluasi kinerja staf laboratorium.
- j) Bertanggung jawab atas monitoring dan evaluasi seluruh pelayanan laboratorium.
- k) Bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko laboratorium.
- l) Bertanggung jawab atas kerahasiaan data dan hasil pemeriksaan pasien.
- m) Bertanggung jawab atas kesiapan unit laboratorium dalam kegiatan akreditasi rumah sakit.

3) Wewenang

- a) Mengatur pembagian tugas dan jadwal kerja petugas laboratorium.
- b) Memberikan arahan dan supervisi kepada seluruh staf laboratorium.
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja petugas laboratorium.
- d) Mengusulkan kebutuhan tenaga laboratorium kepada pimpinan.
- e) Mengusulkan pendidikan dan pelatihan bagi staf laboratorium.
- f) Mengusulkan pengadaan alat, reagen, dan bahan habis pakai.
- g) Menolak penggunaan alat yang tidak laik pakai atau belum terkalibrasi.
- h) Menolak penggunaan reagen yang rusak atau kedaluwarsa.
- i) Menghentikan sementara proses pemeriksaan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keselamatan.
- j) Melakukan tindakan korektif dan preventif terhadap ketidaksesuaian pelayanan laboratorium.
- k) Mengakses data pelayanan laboratorium untuk keperluan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- l) Memberikan rekomendasi perbaikan mutu pelayanan kepada Kepala Instalasi Laboratorium.
- m) Menandatangani dokumen operasional dan laporan sesuai kewenangan yang diberikan rumah sakit.
- n) Berkoordinasi dengan unit lain terkait pelayanan laboratorium.

c. Dokter Spesialis Patologi Anatomi

1) Uraian Tugas

- a) Pelayanan diagnostik patologi anatomi
 - (1) Melakukan pemeriksaan dan interpretasi spesimen histopatologi.

- (2) Melakukan pemeriksaan dan interpretasi sitopatologi.
- (3) Melakukan pemeriksaan biopsi aspirasi jarum halus (FNAB) sesuai kompetensi.
- (4) Melakukan pemeriksaan potong beku (frozen section) bila tersedia.
- (5) Melakukan pemeriksaan imunohistokimia dan pemeriksaan penunjang patologi anatomi lainnya sesuai fasilitas rumah sakit.
- (6) Menetapkan diagnosis patologi anatomi berdasarkan hasil pemeriksaan spesimen

b) Konsultasi dan kolaborasi klinis

- (1) Memberikan konsultasi diagnostik kepada dokter penanggung jawab pasien (DPJP).
- (2) Berpartisipasi dalam konferensi klinikopatologi, tumor board, dan diskusi kasus multidisiplin.
- (3) Memberikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan kepada tenaga medis yang merawat pasien.
- (4) Memberikan rekomendasi pemeriksaan lanjutan apabila diperlukan.

c) Pengelolaan mutu pelayanan

- (1) Menyusun dan mengembangkan standar pelayanan patologi anatomi.
- (2) Melaksanakan pengendalian mutu internal dan eksternal.
- (3) Melakukan validasi metode pemeriksaan dan verifikasi hasil pemeriksaan.
- (4) Berpartisipasi dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit

d) Pengelolaan pelayanan patologi anatomi

- (1) Mengawasi pelaksanaan pelayanan patologi anatomi.
- (2) Membina tenaga teknis patologi anatomi dan tenaga pendukung lainnya.
- (3) Mengembangkan pelayanan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Melakukan evaluasi mutu pelayanan patologi anatomi secara berkala.

2) Tanggung Jawab

- a) Bertanggung jawab atas ketepatan dan keakuratan diagnosis patologi anatomi.
- b) Bertanggung jawab atas validasi dan verifikasi hasil pemeriksaan sebelum diterbitkan.
- c) Bertanggung jawab terhadap mutu pelayanan patologi anatomi.
- d) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengendalian mutu internal dan eksternal.
- e) Bertanggung jawab terhadap kerahasiaan data dan hasil

pemeriksaan pasien.

- f) Bertanggung jawab terhadap pembinaan tenaga teknis patologi anatomi.
- g) Bertanggung jawab terhadap penerapan keselamatan pasien, PPI, dan K3 di unit patologi anatomi.
- h) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan spesimen dan preparat sesuai standar.
- i) Bertanggung jawab terhadap pengembangan pelayanan patologi anatomi.
- j) Bertanggung jawab terhadap pelaporan kegiatan pelayanan kepada pimpinan rumah sakit.
- k) Bertanggung jawab terhadap kesiapan pelayanan patologi anatomi dalam survei akreditasi rumah sakit.

3) Wewenang

- a) Menetapkan diagnosis patologi anatomi berdasarkan hasil pemeriksaan jaringan dan sel.
- b) Memvalidasi, memverifikasi, dan menandatangani hasil pemeriksaan patologi anatomi.
- c) Menentukan jenis pemeriksaan patologi anatomi yang diperlukan sesuai indikasi klinis.
- d) Menentukan kebutuhan pemeriksaan lanjutan seperti imunohistokimia atau pemeriksaan khusus lainnya.
- e) Memberikan konsultasi dan pendapat profesional kepada DPJP dan tenaga kesehatan lainnya.
- f) Menolak spesimen yang tidak memenuhi persyaratan pemeriksaan.
- g) Meminta pengambilan ulang spesimen apabila kualitas spesimen tidak memadai.
- h) Menghentikan penggunaan metode, alat, atau bahan yang tidak memenuhi standar mutu dan keselamatan.
- i) Melakukan audit mutu pelayanan patologi anatomi.
- j) Mengusulkan pengembangan pelayanan, pengadaan alat, reagen, dan teknologi baru.
- k) Memberikan supervisi dan pembinaan kepada tenaga teknis patologi anatomi.
- l) Memberikan rekomendasi rujukan pemeriksaan ke laboratorium lain apabila fasilitas pemeriksaan tidak tersedia di rumah sakit.
- m) Berpartisipasi sebagai anggota atau narasumber dalam komite medis, komite mutu, dan tim akreditasi rumah sakit sesuai penugasan

d. Dokter Spesialis Patologi Klinik

1) Uraian Tugas

- a) Pelayanan diagnostik laboratorium
 - (1) Melakukan supervisi pelayanan laboratorium medik pada seluruh tahapan pemeriksaan (pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik).
 - (2) Melakukan validasi dan interpretasi hasil

pemeriksaan laboratorium.

- (3) Menetapkan dan mengesahkan hasil pemeriksaan laboratorium yang memerlukan verifikasi dokter spesialis.
- (4) Memberikan konsultasi laboratorium kepada dokter penanggung jawab pasien (DPJP).
- (5) Membantu pemilihan jenis pemeriksaan laboratorium yang tepat sesuai indikasi klinis.
- (6) Melakukan evaluasi hasil pemeriksaan laboratorium yang kritis atau tidak sesuai dengan kondisi klinis pasien.

b) Pengelolaan pelayanan laboratorium

- (1) Menyusun dan mengembangkan kebijakan, pedoman, serta standar pelayanan laboratorium.
- (2) Mengawasi pelaksanaan pelayanan laboratorium agar sesuai standar profesi dan SPO.
- (3) Mengembangkan jenis pemeriksaan laboratorium sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit.
- (4) Melakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi pelayanan laboratorium.
- (5) Berkoordinasi dengan unit pelayanan lain terkait kebutuhan pemeriksaan laboratorium

c) Pengelolaan mutu laboratorium

- (1) Memimpin pelaksanaan program Pemantapan Mutu Internal (PMI).
- (2) Mengawasi pelaksanaan Pemantapan Mutu Eksternal (PME).
- (3) Menetapkan indikator mutu pelayanan laboratorium.
- (4) Melakukan validasi metode pemeriksaan laboratorium.
- (5) Melaksanakan audit mutu laboratorium secara berkala.
- (6) Melakukan analisis dan tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian hasil pemeriksaan

d) Pengelolaan keselamatan pasien dan manajemen risiko

- (1) Mengidentifikasi risiko dalam pelayanan laboratorium.
- (2) Mengembangkan sistem pelaporan insiden dan manajemen risiko laboratorium.
- (3) Mengawasi pelaksanaan program keselamatan pasien di laboratorium.
- (4) Berpartisipasi dalam kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).
- (5) Mengawasi penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) laboratorium

2) Tanggung Jawab

- a) Bertanggung jawab atas mutu pelayanan laboratorium medik.

-
- b) Bertanggung jawab atas keakuratan, validitas, dan ketepatan hasil pemeriksaan laboratorium.
 - c) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses pemeriksaan laboratorium sesuai standar profesi.
 - d) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PMI dan PME.
 - e) Bertanggung jawab terhadap validasi metode pemeriksaan laboratorium.
 - f) Bertanggung jawab terhadap penerapan keselamatan pasien dalam pelayanan laboratorium.
 - g) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan manajemen risiko laboratorium.
 - h) Bertanggung jawab terhadap penerapan PPI dan K3 laboratorium.
 - i) Bertanggung jawab terhadap kerahasiaan data dan hasil pemeriksaan pasien.
 - j) Bertanggung jawab terhadap pembinaan tenaga laboratorium.
 - k) Bertanggung jawab terhadap pengembangan pelayanan laboratorium sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - l) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program mutu dan keselamatan rumah sakit yang terkait dengan laboratorium.
 - m) Bertanggung jawab terhadap kesiapan laboratorium dalam survei akreditasi rumah sakit.
 - n) Bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit atau Kepala Instalasi Laboratorium sesuai struktur organisasi rumah sakit

3) Wewenang

- a) Menetapkan, memvalidasi, dan mengesahkan hasil pemeriksaan laboratorium sesuai kompetensinya.
- b) Memberikan interpretasi klinis terhadap hasil pemeriksaan laboratorium.
- c) Menentukan jenis pemeriksaan laboratorium yang diperlukan berdasarkan indikasi medis.
- d) Menentukan pemeriksaan lanjutan (reflex testing) sesuai kebutuhan klinis.
- e) Menolak spesimen yang tidak memenuhi persyaratan pemeriksaan.
- f) Meminta pengambilan ulang spesimen apabila kualitas spesimen tidak memenuhi standar.
- g) Menentukan nilai kritis (critical value) dan tata cara pelaporannya.
- h) Menghentikan penggunaan alat, metode, atau reagen yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keselamatan.
- i) Menyetujui penggunaan metode pemeriksaan baru setelah melalui proses validasi dan verifikasi.
- j) Memberikan konsultasi laboratorium kepada dokter dan tenaga kesehatan lainnya.

- k) Mengusulkan pengadaan alat, reagen, dan teknologi laboratorium baru.
- l) Melakukan supervisi teknis terhadap tenaga ATLM dan petugas laboratorium lainnya.
- m) Memberikan rekomendasi rujukan pemeriksaan ke laboratorium lain apabila pemeriksaan tidak dapat dilakukan di rumah sakit.
- n) Menjadi anggota atau ketua tim mutu laboratorium sesuai penugasan rumah sakit.
- o) Berpartisipasi dalam komite medis, tim keselamatan pasien, tim PPI, tim PMKP, dan tim akreditasi rumah sakit sesuai kewenangan

e. Ahli Teknologi Laboratorium Medik

1) Uraian Tugas

a) Pelayanan pra analitik

- (1) Menerima dan memverifikasi formulir permintaan pemeriksaan laboratorium.
- (2) Melakukan identifikasi pasien sesuai Sasaran Keselamatan Pasien (SKP).
- (3) Melakukan pengambilan spesimen sesuai kompetensi dan kewenangan.
- (4) Memberikan informasi persiapan pemeriksaan kepada pasien.
- (5) Melakukan pelabelan, penerimaan, penyimpanan, dan transportasi spesimen sesuai prosedur.
- (6) Menilai kelayakan spesimen sebelum dilakukan pemeriksaan

b) Pelayanan analitik

- (1) Melaksanakan pemeriksaan laboratorium sesuai bidang kompetensi dan SPO.
- (2) Mengoperasikan alat laboratorium sesuai petunjuk penggunaan dan prosedur kerja.
- (3) Menyiapkan reagen, bahan kontrol, dan bahan pemeriksaan.
- (4) Melakukan pemeriksaan hematologi, kimia klinik, imunologi, mikrobiologi, urinalisis, dan pemeriksaan lainnya sesuai kewenangan.
- (5) Melaksanakan pemeriksaan POCT sesuai penugasan dan kompetensi.
- (6) Mencatat seluruh proses pemeriksaan pada formulir atau sistem informasi laboratorium

c) Pelayanan pasca analitik

- (1) Memeriksa kesesuaian hasil pemeriksaan dengan data pasien.
- (2) Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan sesuai prosedur.
- (3) Melaporkan hasil kritis kepada petugas yang berwenang sesuai regulasi rumah sakit.

- (4) Menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan pasien.
- (5) Menyiapkan hasil pemeriksaan untuk proses validasi oleh petugas yang berwenang
- d) Pengendalian mutu laboratorium
 - (1) Melaksanakan Pemantapan Mutu Internal (PMI).
 - (2) Melaksanakan program Pemantapan Mutu Eksternal (PME) sesuai penugasan.
 - (3) Melakukan pencatatan hasil kontrol mutu.
 - (4) Melaporkan penyimpangan hasil kontrol mutu kepada atasan.
 - (5) Melaksanakan tindakan korektif sesuai instruksi penanggung jawab laboratorium
- e) Pengelolaan sarana dan prasarana
 - (1) Melakukan pemeliharaan harian alat laboratorium.
 - (2) Melaksanakan kalibrasi internal sesuai kewenangan.
 - (3) Memastikan alat dalam kondisi siap pakai.
 - (4) Memantau ketersediaan reagen dan bahan habis pakai.
 - (5) Melaporkan kerusakan alat dan kekurangan logistik kepada atasan
- f) Keselamatan dan pencegahan infeksi
 - (1) Melaksanakan program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).
 - (2) Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai risiko kerja.
 - (3) Melaksanakan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS).
 - (4) Mengelola limbah laboratorium sesuai prosedur.
 - (5) Melaporkan insiden keselamatan kerja dan kejadian tidak diharapkan

2) Tanggung Jawab

- a) Bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan laboratorium sesuai kompetensi dan kewenangan klinis.
- b) Bertanggung jawab terhadap ketepatan identifikasi pasien dan spesimen.
- c) Bertanggung jawab terhadap mutu proses pemeriksaan laboratorium yang dilaksanakan.
- d) Bertanggung jawab terhadap ketepatan pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan.
- e) Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan alat laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya.
- f) Bertanggung jawab terhadap penggunaan reagen dan bahan laboratorium secara efektif dan efisien.
- g) Bertanggung jawab terhadap kerahasiaan data dan hasil pemeriksaan pasien.
- h) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PMI dan kegiatan mutu laboratorium.
- i) Bertanggung jawab terhadap penerapan PPI dan K3RS di

lingkungan laboratorium.

- j) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah laboratorium sesuai prosedur.
- k) Bertanggung jawab melaporkan setiap ketidaksesuaian, insiden, dan risiko yang ditemukan selama pelayanan laboratorium

3) Wewenang

- a) Melaksanakan pemeriksaan laboratorium sesuai kompetensi, STR, SIP, dan kewenangan klinis yang dimiliki.
- b) Melakukan pengambilan spesimen sesuai prosedur dan kompetensi.
- c) Mengoperasikan alat laboratorium yang telah menjadi kewenangannya.
- d) Menolak spesimen yang tidak memenuhi persyaratan pemeriksaan sesuai SPO.
- e) Meminta pengambilan ulang spesimen apabila kualitas spesimen tidak memenuhi standar.
- f) Melakukan pemeriksaan ulang (repeat test) sesuai ketentuan mutu laboratorium.
- g) Melaporkan hasil pemeriksaan kepada petugas yang berwenang sesuai prosedur.
- h) Menghentikan sementara penggunaan alat yang rusak atau tidak memenuhi standar keselamatan.
- i) Melaporkan dan mengusulkan tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian proses pemeriksaan.
- j) Mengakses data laboratorium yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sesuai kewenangannya.
- k) Mengikuti pelatihan, uji kompetensi, kredensial, dan rekredensial sesuai ketentuan rumah sakit.

2.2 Distribusi Ketenagaan

Pelayanan laboratorium sebagaimana meliputi pelayanan patologi klinik yang diselenggarakan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk mendukung pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan penunjang lainnya, dengan distribusi ketenagaan laboratorium sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Distribusi Ketenagaan

Nama Jabatan	Waktu Kerja	Jumlah SDM
Kepala Instalasi Laboratorium	08.00 – 16.00	1 orang
Penanggung Jawab Pelayanan Laboratorium	08.00 – 16.00	1 orang
Tenaga Teknis Analis Kesehatan	07.00 – 14.00	11 orang
	14.00 – 21.00	
	21.00 – 07.00	

2.3 Pengaturan Jaga/Dinas

Pengaturan jaga di instalasi laboratorium Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo sebagai berikut :

Tabel 2.3.1 Pengaturan Jaga

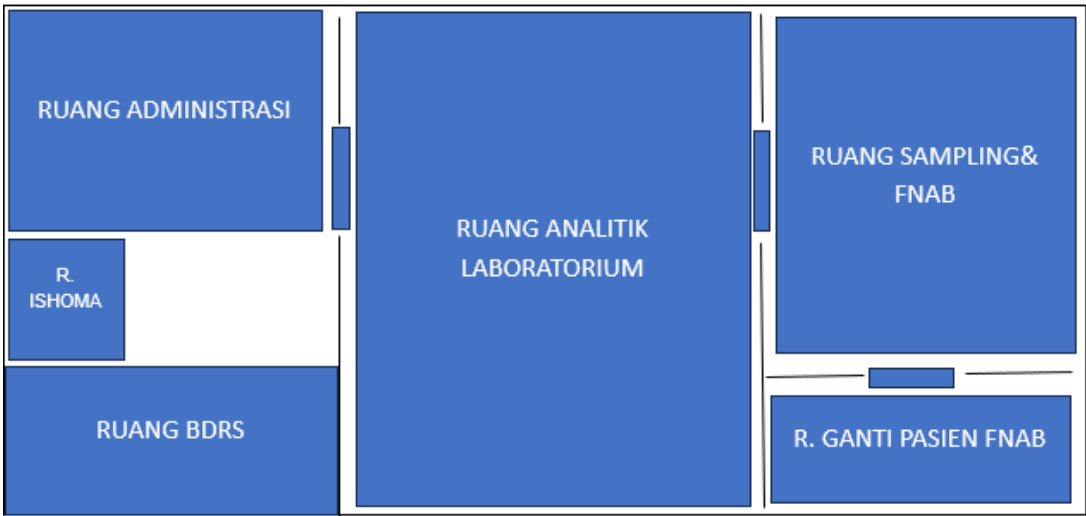
No	Nama Jabatan	Waktu Kerja	Definisi Waktu	Jumlah SDM
1	Kepala Instalasi Laboratorium	1 Shift	08.00 – 16.00	1
2	Penanggung Jawab Pelayanan Laboratorium	1 Shift	08.00 – 16.00	1
3	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Pagi	07.00 – 14.00	5
		Siang	14.00 – 21.00	5
		Malam	21.00 – 07.00	1

*Diluar waktu kerja on c

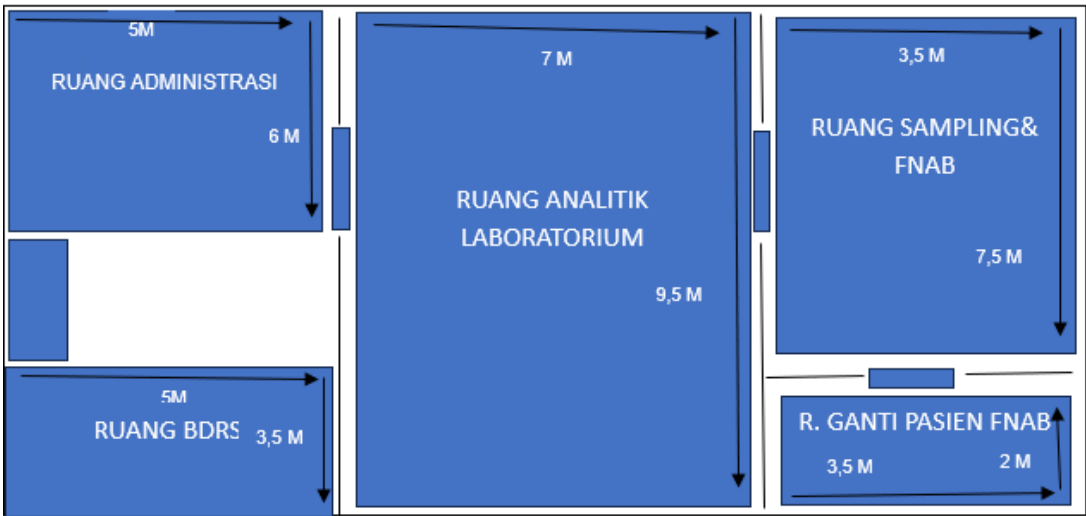
BAB III
STANDAR FASILITAS

3.1 Denah Ruangan

1. LABORATORIUM CENTRAL



2. UKURAN LABORATORIUM CENTRAL



Tabel 3.1. persyaratan minimal bangunan sarana dan prasarana laboratorium klinik Madya :

No	Jenis Kelengkapan	Jumlah / Keterangan (sesuai dengan PMK)	Ukuran
1	Gedung:	Permanen	
	a. Dinding	Tidak tembus cairan dan tahan terhadap desinfektan, mudah diberikan	
	b. Langit – Langit	Terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibersihkan	Tingginya 2,70 – 3,30 m dari lantai.

	c. Pintu	Harus kuat mencegah masuknya binatang liar	Lebar minimal : 1,20 m dantinggi minimal : 2,10 m
	d. Stop Kontak dan saklar		Jarak minimal dari lantai dipasang 1,40 m
2	Ventilasi	Ada	Tinggi minimal 1,00 m dari lantai
	AC	Ada	1PK/20m ²
3	Penerangan Lampu	Ada	1000 lux (untuk pekerjaan yang memerlukan ketelitian dan sinar harus berasal dari tangan petugas)
4	Air Mengalir, Bersih	Ada	
5	Daya Listrik	Sesuai Dengan Kebutuhan	
6	Tata Ruang :		
	a) Ruang Tunggu	Ada	6 m ²
	b) Ruang Pengambilan Spesimen	Ada	6 m ²
	c) Ruang Pemeriksaan dan Administrasi	Ada	15 m ²
	d) Kamar Mandi Pegawai	Ada	

3.2 Standar Fasilitas

1. Standar Bangunan

Fasilitas bangunan dan peralatan di Instalasi Laboratorium memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Letak ruang laboratorium harus memiliki akses yang mudah ke ruang gawat darurat dan ruang rawat jalan dan ruangan mudah di bersihkan.
- b. Desain tata ruang dan alur petugas dan pasien pada ruang laboratorium harus terpisah dan dapat meminimalkan risiko penyebaran infeksi dan lantai harus bersih.
- c. Ruang laboratorium harus memiliki:
 - 1) Saluran pembuangan limbah cair yang dilengkapi dengan pengolahan awal (pretreatment) khusus sebelum dialirkan ke instalasi pengolahan air limbah rumah sakit; dan apabila belum dapat mengelola limbah sendiri dapat bekerja sama dengan instansi yang telah memiliki instalasi pengolahan limbah.
 - 2) Fasilitas penampungan limbah padat medis yang kemudian dikirim ke tempat penampungan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun.

2. Standar Peralatan.

Fasilitas peralatan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan terutama untuk pada kuliatas alat, peralatan harus jamin sensitive pada pengukuran dan memenuhi persyaratan, penaraan dan kalibrasi untuk perlatan tertentu setiap tahun.

Persayaratan minimal peralatan yang tersedia dilaboratorium Madya sesuai dengan PMK No 411 Tahun 2010 Tentang Laboratorium Klinik.

Tabel 3.2 Peralatan minimal laboratorium

No	Jenis Kelengkapan	Standart Lab Madya	Jumlah Keterangan
1	Blood Cell Counter	1	1
2	Autoclave	1	Di CSSD
3	Lampu Bunsen	1	1
4	Tempat tidur pasien	1	1
5	Differensial Counter	1	1
6	Objek Glass	Sesuai Kebutuhan	Ada Sesuai Kebutuhan
7	Cover Glass	Sesuai Kebutuhan	Ada Sesuai Kebutuhan
8	Mikroskop Binokuler	1	1
10	Peralatan Gelas	Sesuai Kebutuhan	Ada Sesuai Kebutuhan
11	Rak Pengecatan	1	1
12	Rak Tabung Reaksi	1	5
13	Refrigerator	1	1
14	Centrifuge	1	2
15	Sterilisator	1	Tidak ada
16	Stopwatch	1	1
17	Tabung Reaksi	Sesuai Kebutuhan	Ada Sesuai Kebutuhan
18	Tabung Centrifuge	Sesuai Kebutuhan	Ada Sesuai Kebutuhan
19	Termometer Suhu	1	4
20	Torniquet	1	Ada Sesuai Kebutuhan
21	Alat Westergren	1 Set	Ada Sesuai Kebutuhan
22	Autoanalyzer Kimia Klinik	-	1
23	Autoanalyzer Hematologi	-	1

24	Autoanalyzer Elektrolit	-	1
25	Autoanalyzer Hemostasis	-	1
27	Autoanalyzer Imunologi	-	1
28	Mikropipet	1	4

Perlengkapan Keselamatan Dan Keamanan Laboratorium
 Berdasarkan PMK N0 66 Tahun 2010 tentang Keselamatan dan kesehatan kerja Rumah Sakit untuk penanganan dan pemaparan yang selalu tersedia untuk menanggulani bahan berbahaya dan beracun.

Tabel 3.3 Perlengkapan Keselamatan Dan Keamanan Laboratorium

No	Jenis Kelengkapan	Standart Lab Madya	Jumlah Keterangan
1	Lemari bahan berbahaya dan beracun.	Sesuai Kebutuhan	1
2.	Alat pemadam api ringan (APAR)	1	1
3	Penyiram Badan	Sesuai Kebutuhan	Belum ada
4	APD (Sarung Tangan, Masker, Jas Lab)	Sesuai Kebutuhan	Ada
5.	Pencuci Mata (Eye Washer)	1	Ada
6	Wastafel Dengan Sabun Cair	1	Ada
7	Hand Scrub	1	Ada
8	Spil Kit	1	Ada
9	Rambu dan symbol bahan berbahaya beracun	Sesuai kebutuhan	Ada

BAB IV

KEMAMPUAN PELAYANAN

4.1 Kemampuan Pelayanan

Kemampuan Pelayanan Laboratorium pada Rumah Sakit Prima Husada mengacu pada kemampuan laboratorium untuk mendukung pelayanan medik dasar dan spesialis dasar yang tersedia di rumah sakit tersebut.

1. Pelayanan Patologi Klinik Dasar

a. Pelayanan Hematologi

- 1) Hemoglobin (Hb)
- 2) Hematokrit (Ht)
- 3) Leukosit
- 4) Trombosit
- 5) Hitung jenis leukosit
- 6) Laju Endap Darah (LED)

b. Pelayanan Kimia Klinik

- 1) Glukosa darah
- 2) Ureum
- 3) Kreatinin
- 4) Asam urat
- 5) Kolesterol
- 6) Trigliserida
- 7) Fungsi hati dasar (SGOT, SGPT)

c. Pelayanan Urinalisis

- 1) Urin lengkap
- 2) Protein urin
- 3) Glukosa urin
- 4) Sedimen urin
- 5) Tes kehamilan (HCG urin)
- 6) Mikroalbumin urin sesuai fasilitas

d. Pemeriksaan feses rutin.

e. Pelayanan Imunologi dan Serologi

- 1) HBsAg
- 2) Anti HCV
- 3) HIV sesuai program nasional
- 4) Widal
- 5) Dengue (NS1, IgG, IgM)
- 6) CRP
- 7) ASO
- 8) Golongan darah ABO dan Rhesus
- 9) Uji kehamilan (test pack/ β -hCG sesuai fasilitas)
- 10) Pemeriksaan serologi dasar sesuai kemampuan laboratorium.

f. Pelayanan Mikrobiologi Dasar

- 1) Pemeriksaan mikroskopis sputum BTA
- 2) Pemeriksaan malaria
- 3) Pemeriksaan jamur sederhana
- 4) Pewarnaan Gram sederhana sesuai kebutuhan klinis.

g. Pelayanan Koagulasi Dasar

- 1) Waktu perdarahan (Bleeding Time)
- 2) Waktu pembekuan (Clotting Time)

- 3) PT dan APTT (bila fasilitas tersedia).
 - h. Pelayanan Bank Darah Transfusi
 - 1) Pemeriksaan golongan darah.
 - 2) Uji silang serasi (crossmatch).
 - 3) Penyimpanan dan distribusi darah sesuai kewenangan dan kerja sama dengan unit transfusi darah.
 - i. Pelayanan Penunjang Gawat Darurat 24 Jam
 Laboratorium harus mampu memberikan pemeriksaan cito untuk mendukung:
 - 1) Instalasi Gawat Darurat (IGD).
 - 2) Rawat inap.
 - 3) Kamar operasi.
 - 4) Pelayanan kebidanan dan neonatal.
2. Pelayanan Patologi Anatomi
- a. Histopatologi
 - b. Sitopatologi Pap smear
 - c. Sitologi Cairan Tubuh
 - d. Biopsi Jarum Halus (FNAB)

Tabel 4.1 Kemampuan Pelayanan Di Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

No	Pemeriksaan	Jenis pemeriksaan
1	Hematologi	Darah Lengkap (CBC)
		Hemoglobin
		Leukosit
		Trombosit
		Eritrosit
		Hematokrit
		MCV
		MCH
		MCHC
		Hapusan darah tepi
2	Kimia klinik	SGOT
		SGPT
		Urea
		Kreatinin
		Uric acid
		Glukosa Puasa/ 2 jam PP / Sesaat
		Choleterol Total
		Trigliserida
		LDL Cholesterol
		HDL Cholesterol
		Hba1C
		Albumin
		Bilirubin Total / Direct / Indirect
		Total protein
		Albumin
		Globulin

3	Faal Hemostasis	PPT
		KPPT
		INR
4	Elektrolite	Na, Ka, Cl,Calsium
		Blood gas analysis
5	Urine Lengkap	Mikroskopis dan makroskopis urine
		PPT (Plano Test)
		Narkoba
6	Imunologi	Free T4
		TSH
		Hbs Ag
		Troponin
		Shyphilis
		Igm Anti salmonela
		Widal
		Rheumatoid faktor
7	Mikrobiologi	BTA
		Gram
		Hapusan malaria
		Telur cacing
8	Feses	Feses lengkap
9	BDRS	Golongan darah
		Uji silang serasi (crossmatch)
		Distribusi darah
10	Patologi Anatomi	Histopatologi
		Sitologi
		FNAB

BAB V

TATA LAKSANA PELAYANAN

5.1 Pengelolaan Spesimen

1. Permintaan Pemeriksaan

- a. Permintaan pemeriksaan oleh dokter pengirim
 - 1) Dokter melakukan login ke SIMRS menggunakan akun masing-masing.
 - 2) Dokter membuka data pasien yang akan dilakukan pemeriksaan laboratorium.
 - 3) Dokter memilih menu "Permintaan Laboratorium".
 - 4) Dokter menginput:
 - a) Jenis pemeriksaan yang diminta.
 - b) Diagnosis atau indikasi klinis.
 - c) Prioritas pemeriksaan (rutin atau cito).
 - d) Informasi klinis lain yang diperlukan
 - 5) Dokter melakukan verifikasi data permintaan.
 - 6) Dokter mengirimkan permintaan secara elektronik melalui SIMRS.
 - 7) Sistem secara otomatis mengirimkan order pemeriksaan ke unit laboratorium
- b. Verifikasi permintaan oleh petugas laboratorium
 - 1) Petugas laboratorium login ke SIMRS.
 - 2) Petugas membuka daftar permintaan pemeriksaan yang masuk.
 - 3) Petugas memverifikasi:
 - a) Identitas pasien.
 - b) Kelengkapan data permintaan.
 - c) Kesesuaian jenis pemeriksaan.
 - d) Prioritas pemeriksaan
 - 4) Jika terdapat ketidaksesuaian atau data tidak lengkap, petugas melakukan konfirmasi kepada unit pengirim.
 - 5) Jika permintaan lengkap, petugas menerima order pemeriksaan dalam sistem.

2. Pengambilan, Pengumpulan, dan Identifikasi Spesimen

a. Pengambilan spesimen

- 1) Verifikasi identitas pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medis, atau identitas lainnya).
- 2) Pastikan terdapat formulir permintaan pemeriksaan yang lengkap.
- 3) Jelaskan prosedur pengambilan spesimen kepada pasien dan lakukan persiapan yang diperlukan.
- 4) Siapkan alat, bahan, dan wadah spesimen yang sesuai.
- 5) Lakukan pengambilan spesimen sesuai teknik aseptik dan standar prosedur operasional.
- 6) Pastikan jumlah atau volume spesimen mencukupi untuk pemeriksaan yang diminta.
- 7) Hindari kontaminasi dan kerusakan spesimen selama proses pengambilan.
- 8) Catat tanggal, waktu, dan nama petugas yang melakukan pengambilan.

b. Pengumpulan Spesimen

- 1) Gunakan wadah yang sesuai dengan jenis spesimen dan

-
- pemeriksaan.
- 2) Pastikan wadah bersih, steril (bila diperlukan), dan tertutup rapat.
 - 3) Kumpulkan spesimen sesuai petunjuk masing-masing jenis pemeriksaan, misalnya:
 - a) Urine sewaktu, urine pagi, atau urine 24 jam.
 - b) Feses segar.
 - c) Sputum pagi.
 - d) Jaringan biopsi dalam larutan fiksatif.
 - 4) Pastikan volume spesimen memenuhi persyaratan pemeriksaan.
 - 5) Simpan spesimen sesuai ketentuan suhu dan waktu sebelum dikirim ke laboratorium.
 - 6) Dokumentasikan waktu pengumpulan spesimen.
- c. Identifikasi Spesimen
- 1) Lakukan pelabelan segera setelah spesimen diambil atau dikumpulkan.
 - 2) Label spesimen minimal memuat:
 - a) Nama lengkap pasien.
 - b) Nomor rekam medis atau nomor identitas.
 - c) Tanggal lahir
 - 3) Cocokkan identitas pada label spesimen dengan formulir permintaan pemeriksaan.
 - 4) Gunakan barcode atau sistem identifikasi elektronik bila tersedia.
 - 5) Verifikasi ulang identitas sebelum spesimen dikirim atau diproses.
 - 6) Setiap ketidaksesuaian identitas harus segera dilaporkan dan ditindaklanjuti sesuai prosedur.
- d. Kriteria Spesimen yang ditolak
- 1) Tidak memiliki label identitas.
 - 2) Identitas pada spesimen dan formulir tidak sesuai.
 - 3) Wadah tidak sesuai atau rusak.
 - 4) Volume spesimen tidak mencukupi.
 - 5) Spesimen terkontaminasi atau mengalami kerusakan.
 - 6) Pengumpulan tidak sesuai persyaratan pemeriksaan.
3. Pengiriman, Pembuangan, Penyimpanan dan Pengawetan Spesimen
- a. Pengiriman spesimen
- 1) Pastikan spesimen telah diberi label identitas yang lengkap dan benar.
 - 2) Cocokkan identitas pada wadah spesimen dengan formulir permintaan pemeriksaan.
 - 3) Gunakan wadah yang tertutup rapat dan tidak bocor.
 - 4) Tempatkan spesimen dalam kemasan atau kontainer khusus (coolbox) khusus untuk transportasi specimen.
 - 5) Kirim spesimen sesegera mungkin setelah pengambilan sesuai waktu yang dipersyaratkan.
 - 6) Pertahankan suhu pengiriman sesuai jenis spesimen:
 - a) Suhu ruang (20–25°C).
 - b) Suhu dingin (2–8°C).
 - c) Suhu beku ($\leq -20^{\circ}\text{C}$ atau sesuai ketentuan pemeriksaan).
 - d) Catat waktu pengiriman dan penerimaan spesimen.
 - 7) Petugas wajib menerapkan prinsip keselamatan dan keamanan biologis selama transportasi.
- b. Penyimpanan Spesimen
- 1) Simpan spesimen sesuai persyaratan masing-masing jenis pemeriksaan.

-
- 2) Pisahkan spesimen berdasarkan kategori dan risiko biologis.
 - 3) Gunakan lemari pendingin atau freezer yang terkalibrasi bila diperlukan.
 - 4) Monitor dan catat suhu penyimpanan secara berkala.
 - 5) Hindari paparan sinar matahari langsung dan kontaminasi silang.
 - 6) Terapkan sistem identifikasi dan penelusuran spesimen yang jelas.
 - 7) Simpan spesimen hanya selama waktu yang ditentukan sesuai kebijakan laboratorium.
- c. Pengawetan Spesimen
- 1) Gunakan bahan pengawet sesuai jenis spesimen dan pemeriksaan yang diminta.
 - 2) Pastikan jenis tabung atau wadah yang digunakan sesuai, misalnya:
 - a. EDTA untuk pemeriksaan hematologi.
 - b. Natrium sitrat untuk pemeriksaan koagulasi.
 - c. Heparin untuk pemeriksaan tertentu.
 - d. Formalin untuk spesimen jaringan (histopatologi).
 - 3) Campurkan spesimen dengan bahan pengawet sesuai prosedur yang berlaku.
 - 4) Simpan spesimen pada suhu yang direkomendasikan.
 - 5) Hindari pembekuan atau pemanasan yang tidak sesuai dengan persyaratan pemeriksaan.
- d. Pembuangan Spesimen
- 1) Buang spesimen yang telah selesai diperiksa dan melewati masa retensi sesuai kebijakan laboratorium.
 - 2) Perlakukan seluruh sisa spesimen sebagai limbah infeksius.
 - 3) Buang spesimen cair ke sistem pengelolaan limbah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 4) Buang wadah, tabung, dan bahan terkontaminasi ke tempat limbah medis infeksius.
 - 5) Buang jarum dan benda tajam ke dalam safety box tanpa melakukan penutupan ulang (recapping).
 - 6) Lakukan dekontaminasi bila diperlukan sebelum pembuangan.
 - 7) Dokumentasikan proses pemusnahan atau pembuangan spesimen sesuai prosedur laboratorium.
 - 8) Gunakan APD selama proses penanganan dan pembuangan limbah.
4. Penerimaan, Penyimpanan, Telusur Spesimen (*Tracking*)
- a. Penerimaan Spesimen
- 1) Petugas menerima spesimen beserta formulir permintaan pemeriksaan.
 - 2) Verifikasi kesesuaian identitas pasien pada spesimen dan formulir permintaan, meliputi:
 - a) Nama pasien.
 - b) Nomor rekam medis atau nomor identifikasi.
 - c) Tanggal dan waktu pengambilan spesimen.
 - d) Jenis spesimen.
 - 3) Periksa kondisi spesimen, meliputi:
 - a) Wadah sesuai dan tertutup rapat.
 - b) Label terbaca dengan jelas.
 - c) Volume spesimen mencukupi.

- d) Tidak terjadi kebocoran, hemolisis, atau kontaminasi (sesuai jenis pemeriksaan).
- 4) Catat penerimaan spesimen dalam buku register atau sistem informasi laboratorium. Berikan nomor registrasi atau barcode untuk identifikasi spesimen.
- 5) Spesimen yang tidak memenuhi syarat dicatat dan ditindaklanjuti sesuai prosedur penolakan spesimen.
- b. Penyimpanan Spesimen
 - 1) Simpan spesimen sesuai persyaratan suhu dan waktu masing-masing pemeriksaan.
 - 2) Kelompokkan spesimen berdasarkan jenis dan kebutuhan penyimpanan.
 - 3) Beri identifikasi yang jelas pada setiap spesimen.
 - 4) Simpan pada lokasi yang telah ditentukan, seperti:
 - a) Suhu ruang (20–25°C).
 - b) Lemari pendingin (2–8°C).
 - c) Freezer (-20°C atau lebih rendah).
 - 5) Catat lokasi penyimpanan dalam sistem atau log penyimpanan.
 - 6) Pantau dan dokumentasikan suhu penyimpanan secara berkala.
 - 7) Batasi akses hanya kepada petugas yang berwenang.
- c. Telusur spesimen (Tracking)
 - 1) Setiap spesimen diberikan nomor unik atau barcode.
 - 2) Catat setiap tahapan penanganan spesimen, meliputi:
 - a) Penerimaan.
 - b) Penyimpanan.
 - c) Distribusi ke unit pemeriksaan.
 - d) Pemeriksaan.
 - e) Penyimpanan pasca-pemeriksaan.
 - f) Pemusnahan.
 - 3) Dokumentasikan tanggal, waktu, lokasi, dan petugas yang menangani spesimen.
 - 4) Lakukan penelusuran segera apabila terjadi:
 - a) Kehilangan spesimen.
 - b) Keterlambatan pemeriksaan.
 - c) Ketidaksesuaian identitas.
 - d) Keluhan terkait hasil pemeriksaan.
 - 5) Simpan rekaman tracking sesuai kebijakan retensi dokumen laboratorium.

5. Pemeriksaan Laboratorium

1) Tahap Pra Analitik

1) Penerimaan permintaan pemeriksaan

- a) Petugas menerima permintaan pemeriksaan melalui SIMRS atau formulir permintaan laboratorium.
- b) Petugas memverifikasi:
 - Nama pasien.
 - Nomor rekam medis.
 - Tanggal lahir/umur.
 - Ruangan atau unit pengirim.
 - Jenis pemeriksaan yang diminta.
 - Nama dokter pengirim.

-
- c) Petugas memastikan permintaan pemeriksaan lengkap dan jelas.
 - 2) Identifikasi pasien
 - a) Petugas melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas pasien.
 - b) Untuk pasien rawat inap dilakukan verifikasi menggunakan gelang identitas pasien.
 - c) Ketidaksesuaian identitas harus diselesaikan sebelum pengambilan spesimen.
 - 3) Pengambilan spesimen
 - a) Petugas menjelaskan prosedur kepada pasien.
 - b) Petugas melakukan pengambilan spesimen sesuai jenis pemeriksaan.
 - c) Petugas menggunakan APD sesuai ketentuan.
 - d) Spesimen ditempatkan pada wadah yang sesuai.
 - e) Label identitas pasien dipasang segera setelah spesimen diambil
 - 4) Transportasi dan Penerimaan Spesimen
 - a) Spesimen dikirim ke laboratorium sesuai ketentuan transportasi spesimen.
 - b) Petugas laboratorium memeriksa:
 - Kesesuaian identitas.
 - Jenis spesimen.
 - Volume spesimen.
 - Kondisi spesimen.
 - c) Spesimen yang tidak memenuhi syarat ditolak dan diminta pengambilan ulang sesuai prosedur.
 - 2) Tahap Analitik
 - 1) Persiapan pemeriksaan
 - a) Petugas menyiapkan alat, reagen, bahan kontrol, dan perlengkapan pemeriksaan.
 - b) Petugas memastikan alat dalam kondisi baik dan telah dilakukan pemeliharaan sesuai jadwal.
 - c) Petugas melakukan kontrol mutu harian sebelum pemeriksaan pasien
 - 2) Pelaksanaan pemeriksaan
 - a) Pemeriksaan dilakukan sesuai metode dan SOP masing-masing parameter.
 - b) Petugas mengoperasikan alat sesuai petunjuk penggunaan.
 - c) Petugas mencatat setiap proses pemeriksaan pada formulir kerja atau sistem informasi laboratorium.
 - d) Bila ditemukan hasil yang tidak sesuai atau meragukan, dilakukan pemeriksaan ulang sesuai prosedur.
 - 3) Pengendalian mutu
 - a) Petugas melaksanakan Pemantapan Mutu Internal (PMI).
 - b) Hasil kontrol mutu dievaluasi sebelum hasil pasien dikeluarkan.
 - c) Ketidaksesuaian hasil kontrol mutu harus ditindaklanjuti sebelum pemeriksaan dilanjutkan.

- 3) Tahap Pasca Analitik
 - 1) Verifikasi hasil
 - a) Petugas memeriksa kesesuaian hasil pemeriksaan dengan identitas pasien.
 - b) Hasil yang tidak wajar atau kritis dilakukan verifikasi ulang.
 - c) Hasil pemeriksaan direview oleh petugas yang berwenang.
 - 2) Validasi hasil
 - a) Hasil pemeriksaan divalidasi sesuai ketentuan laboratorium.
 - b) Untuk pemeriksaan tertentu dilakukan validasi oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik atau pejabat yang berwenang
 - 3) Pelaporan hasil
 - a) Hasil pemeriksaan diinput ke dalam SIMRS.
 - b) Hasil tersedia untuk dokter pengirim setelah proses validasi selesai.
 - c) Hasil kritis segera dilaporkan kepada DPJP atau perawat penanggung jawab sesuai prosedur pelaporan nilai kritis.
 - d) Seluruh komunikasi hasil kritis didokumentasikan
 - 4) Penyimpanan dan arsip
 - a) Hasil pemeriksaan disimpan dalam sistem informasi laboratorium dan rekam medis pasien.
 - b) Data laboratorium dipelihara sesuai kebijakan retensi dokumen rumah sakit

Tabel 5.1.1 Pemeriksaan berdasarkan Metode dan Jenis Reagen

No	Kelompok Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Metode	Reagen
1	Hematologi	Darah Lengkap (Tanpa LED)	5 diff	LH Lyse,Diff Lyse,Diluent
		Hemoglobin		
		Leukosit		
		Trombosit		
		Hapusan darah tepi		Indoreagen
2	Kimia klinik	SGOT	Enzimatik	Thermo Reagen (basah)
		SGPT	Enzimatik	
		Urea	Colourimetri	
		Kreatinin	Colourimetri	
		Uric acid	Colourimetri	
		Glukosa	Colourimetri	
		Choleterol Total	Colourimetri	
		Trigliserida	Colourimetri	
		LDL Cholesterol	Colourimetri	
		HDL Cholesterol	Colourimetri	
		Albumin	Enzimetik	
		Bilirubin	Enzimatik	
		Total protein	Enzimatik	
3	Faal Hemostasis	PPT	Koagulasi	Behnk elektronik
		aPTT	Koagulasi	
		INR	Koagulasi	
4	Elektrolite	Natrium, Kalium Clorida,Calsium	Enzimatik	

5	Urine Lengkap	Mikroskopis dan makroskopis urine	Colourimetri	V- Care
		PPT (Pregnocion Plano Test)		V – Care
6	Imunologi	FREE T4	Enzimatik	Icroma
		TSH	Enzimatik	Icroma
		Hbs Ag		V-Care
		Troponin		Icroma
7	Mikrobiologi	BTA		Indoreagen
		Gram		Indoreagen

6. Pencatatan Dan Pelaporan Hasil
- a. Semua hasil pemeriksaan dicatat dalam Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS)
 - b. Pencatatan mencakup:
 - 1) Identitas pasien (nama, nomor rekam medis).
 - 2) Jenis pemeriksaan.
 - 3) Tanggal dan waktu pemeriksaan.
 - 4) Hasil pemeriksaan.
 - 5) Nilai rujukan (reference value).
 - 6) Satuan hasil.
 - 7) Identitas petugas pemeriksa.
 - c. Hasil abnormal atau kritis harus ditandai khusus.
 - d. Setiap koreksi hasil harus disertai alasan, tanggal, dan paraf petugas yang melakukan koreksi.
 - e. Data harus disimpan dengan aman untuk menjaga kerahasiaan pasien.
 - f. Validasi Hasil
 - 1) Proses validasi dilakukan untuk memastikan
 - 2) Hasil sesuai dengan kondisi klinis dan teknis pemeriksaan.
 - 3) Tidak ada kesalahan input atau transkripsi data.
 - 4) Alat dan reagen dalam kondisi baik saat pemeriksaan. \Dilakukan oleh petugas yang berwenang (analis senior atau dokter patologi klinik).
 - g. Pelaporan Hasil Laboratorium
 - 1) Hasil yang sudah divalidasi disusun dalam format laporan resmi.
 - 2) Laporan dapat disampaikan melalui:
 - a) Cetak hasil (hardcopy).
 - b) Sistem elektronik (SIMRS).
 - c) Pengiriman langsung ke unit pelayanan.
 - 3) Laporan mencantumkan:
 - a) Identitas pasien.
 - b) Jenis pemeriksaan.
 - c) Hasil dan nilai rujukan.
 - d) Interpretasi (jika diperlukan).
 - e) Tanggal dan waktu pelaporan.
 - f) Tanda tangan atau identitas penanggung jawab.
 - 4) Hasil cito atau kritis harus segera dilaporkan secara lisan/telepon kemudian dikonfirmasi tertulis.
7. Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Spesimen
- a. Pemantauan
 - 1) Pemantauan identifikasi pasien dan spesimen

-
- a) Petugas laboratorium melakukan pemantauan terhadap:
 - Kesesuaian nama pasien.
 - Nomor rekam medis.
 - Tanggal lahir atau identitas lain.
 - Kesesuaian label spesimen dengan formulir permintaan pemeriksaan.
 - Penggunaan minimal dua identitas pasien.
 - b) Hasil pemantauan dicatat dalam formulir monitoring identifikasi spesimen.
- 2) Pemantauan pengambilan spesimen
Pemantauan dilakukan terhadap:
 - a) Kepatuhan petugas dalam melakukan identifikasi pasien.
 - b) Teknik pengambilan spesimen.
 - c) Penggunaan tabung atau wadah yang sesuai.
 - d) Kecukupan volume spesimen.
 - e) Ketepatan waktu pengambilan spesimen.
 - f) Penggunaan APD oleh petugas
 - 3) Pemantauan transportasi spesimen
Pemantauan meliputi:
 - a) Ketepatan waktu pengiriman spesimen.
 - b) Kondisi wadah transportasi.
 - c) Suhu penyimpanan selama pengiriman (jika dipersyaratkan).
 - d) Keamanan dan integritas spesimen selama transportasi.
 - 4) Pemantauan penerimaan spesimen
Petugas laboratorium memantau:
 - a) Kesesuaian identitas pasien.
 - b) Kesesuaian jenis spesimen.
 - c) Kondisi fisik spesimen.
 - d) Volume spesimen.
 - e) Waktu penerimaan spesimen.
 - 5) Pemantauan penyimpanan dan pemusnahan spesimen
Pemantauan dilakukan terhadap:
 - a) Suhu penyimpanan spesimen.
 - b) Masa retensi spesimen.
 - c) Sistem dokumentasi penyimpanan.
 - d) Proses pemusnahan spesimen sesuai ketentuan limbah medis dan B3.
- b. Evaluasi
- 1) Pengumpulan data
Data dikumpulkan dari:
 - a) Formulir insiden laboratorium.
 - b) Laporan mutu laboratorium.
 - c) Audit internal laboratorium
 - 2) Analisis data
Data dianalisis untuk mengetahui:
 - a) Penyebab penolakan spesimen.
 - b) Kesalahan identifikasi pasien.
 - c) Kesalahan pelabelan spesimen.
 - d) Spesimen hemolisis.
 - e) Spesimen bekuan.
 - f) Spesimen kurang volume.
 - g) Keterlambatan pengiriman spesimen.

5.2 Kerangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan
Tabel 5.2.1 Kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan

No	Pemeriksaan	Jenis pemeriksaan	Waktu Cyto	Waktu Elektif
1	Hematologi	Darah Lengkap (CBC)	< 10 menit	30 Menit
		Hemoglobin	< 10 Menit	30 Menit
		Leukosit	< 10 menit	30 Menit
		Trombosit	< 20 menit	30 Menit
		Hapusan darah tepi	Sesuai kesepakatan	Sesuai kesepakatan
		Darah lengkap dengan LED	60 Menit	60 menit
2	Kimia klinik	SGOT	30 menit	60 Menit
		SGPT	30 menit	60 Menit
		Urea	30 menit	60 Menit
		Kreatinin	30 menit	60 Menit
		Uric acid	30 menit	60 Menit
		Glukosa (POCT)	5 menit	60 Menit
		Glukosa analysis	bila konfirmasi 30 Menit	60 menit
		Choleterol Total	30 menit	60 Menit
		Trigliserida	30 menit	60 Menit
		LDL Cholesterol	30 menit	60 Menit
		HDL Cholesterol	30 menit	60 Menit
		Hba1C	15 menit	30 Menit
		Albumin	30 menit	60 Menit
		Bilirubin	30 menit	60 Menit
		Total protein	30 menit	60 menit
3	Faal Hemostasis	PPT	20 menit	30 Menit
		KPPT	20 menit	30 Menit
		INR	20 menit	30 Menit
4	Elektrolite	Na, Ka, Cl,Calsium	30 Menit	45 Menit
		Blood gas analysis	15 Menit	30 Menit
5	Urine Lengkap	Mikroskopis dan makroskopis urine	15 Menit	20 Menit
		PPT (Plano Test)	10 Menit	20 menit
		narkoba	10 menit	20 menit
6	Imunologi	TSH	60 menit	60 menit
		FREE T4	60 Menit	60 menit
		TROPONIN I	60 menit	60 menit
		Shyphilis		
		Thypoid		
7	Mikrobi ologi	BTA	Sesuai jadwal	Sesuai jadwal

5.3 Nilai Kritis Laboratorium

1. Identifikasi Nilai Kritis

- a. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan spesimen sesuai prosedur.
- b. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan daftar nilai kritis yang telah ditetapkan oleh rumah sakit dan disahkan oleh dokter penanggung jawab laboratorium.

2. Verifikasi Hasil Nilai Kritis

- a. Analis/Tenaga Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) melakukan verifikasi terhadap hasil yang termasuk kategori kritis.
- b. Verifikasi meliputi:
 - 1) Memastikan identitas pasien sesuai.
 - 2) Memastikan tidak ada kesalahan pra-analitik, analitik, maupun pasca-analitik.
 - 3) Mengulang pemeriksaan bila diperlukan sesuai kebijakan laboratorium.
 - 4) Memastikan alat dan kontrol mutu dalam kondisi baik.
- c. Setelah hasil dinyatakan valid, petugas segera melaporkan kepada penanggung jawab yang berwenang.

3. Pelaporan Nilai Kritis

- a. Hasil nilai kritis harus dilaporkan segera setelah diverifikasi.
- b. Pelaporan dilakukan kepada:
 - 1) Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP).
 - 2) Dokter jaga.
 - 3) Perawat penanggung jawab pasien.
- c. Media pelaporan dapat melalui:
 - 1) Telepon.
 - 2) Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
 - 3) Sarana komunikasi resmi lainnya yang ditetapkan rumah sakit.
- d. Pelaporan harus dilakukan dalam batas waktu yang ditetapkan rumah sakit (misalnya ≤ 30 menit setelah hasil tervalidasi).

4. Proses *Read Back*

Untuk memastikan ketepatan komunikasi:

- a. Petugas laboratorium menyampaikan:
 - 1) Nama pasien.
 - 2) Nomor rekam medis.
 - 3) Jenis pemeriksaan.
 - 4) Nilai kritis yang ditemukan.
- b. Penerima informasi wajib mengulangi kembali (*read back*) seluruh informasi yang diterima.
- c. Petugas laboratorium melakukan konfirmasi kebenaran hasil yang diulang.
- d. Hasil *read back* didokumentasikan.

5. Dokumentasi Nilai Kritis

- a. Petugas laboratorium mencatat:
 - 1) Identitas pasien.
 - 2) Jenis pemeriksaan.
 - 3) Hasil nilai kritis.
 - 4) Tanggal dan jam hasil diperoleh.
 - 5) Tanggal dan jam pelaporan.
 - 6) Nama petugas laboratorium yang melapor.

- 7) Nama penerima laporan.
- 8) Hasil verifikasi read back.
- 9) Tindak lanjut yang dilakukan
- b. Dokumentasi dapat dilakukan pada
 - 1) SIMRS
 - 2) Formulir pelaporan nilai kriti
- 6. Tindak Lanjut Nilai Kritis
 - a. Dokter atau tenaga kesehatan yang menerima laporan segera melakukan asesmen pasien.
 - b. Dilakukan tindakan medis sesuai kondisi klinis pasien.
 - c. Tindak lanjut dicatat dalam rekam medis pasien.
 - d. Bila diperlukan dilakukan pemeriksaan ulang untuk pemantauan kondisi pasien.

Tabel 5.3.1 Nilai Kritis Laboratorium

No	Tes Pemeriksaan	Nilai Kritis	Satuan
1	Hematologi		
	HCT	< 20 atau > 60	%
	Hb	< 7 atau > 20	g/dl
	Trombosit Dewasa	< 50.000 atau > 1.000.000	10 ³ /ul
	Trombosit Anak	< 20.000 atau > 1.000.000	10 ³ /ul
	Leukosit	< 2.000 atau > 25.000	10 ³ /ul
	APTT	> 100	Detik
	PPT	> 30 atau > 3x nilai kontrol	Detik
	Penemuan Sel Blast Dihapusan Darah Tepi	-	-
	Penemuan Sel Asing Disumsum Tulang	-	-
2	Kimia Klinik		
	Troponin I	> 100	ng/dl
	CKMB	> 200	uL
	Glukosa	< 45 atau > 800	mg/dl
	Glukosa Neonatus	< 30 atau > 300	mg/dl
	Creatinin	> 5,0	mg/dl
3	Elektrolit		
	Natrium	< 120 atau > 160	mmol/L
	Kalium	< 2,8 atau > 6,2	mmol/L
	Kalium Neonatus	< 2,5 atau > 8,0	mmol/L
	Cairan Tubuh (Pleura, Serebrosinal, Asites)		

4	Glukosa	< 80 Kadar glukosa darahnya	%
	Total Protein	> 45	mg/dl
	Leukosit	> 10	/ul
	Pengecatan Bakteri	(+)	-
	Ditemukan Sel Asing		-
5	Urinalisa		
	Glukosaria	> 2+	
	Keton	> 2+	
	Ditemukan Kristal Patologis	Uric Acid, Sistein, Leusin, Tirosin	
	Albuminaria	> 2+	
	Eritrosit	> 2+	
	Leukosit	> 2+	

Tabel 5.3.2 Rentang Nilai Normal Laboratorium

No	Tes Pemeriksaan	Nilai Normal Pria	Nilai Normal Wanita	Satuan
1	Hemoglobin	13,0 – 16,0	11,0 – 14,0	g/dl
2	Hematokrit	40 – 45	35 – 47	%
3	MCV	80 – 100	80 – 100	FL
4	MCH	26 – 34	26 – 34	Pg
5	MCHC	32 – 36	32 – 36	g/dl
6	RBC	4,4 – 5,9	3,8 – 5,2	10 ⁶ /ul
7	RDW	11,5 – 14,5	11,5 – 14,5	%
8	WBC	3,8 – 10,6	3,6 – 11,0	10 ³ /ul
9	Hitung Jenis Diff			
10	Limfosit	25 – 40	25 – 40	%
11	Monosit	2 – 8	2 – 8	%
12	Granulosit	50 – 70	50 – 70	%
13	Trombosit	150 – 440	150 – 440	10 ³ /ul
14	MPV	6,8 – 10,0	6,8 – 10,0	Fl
12	LED	0 – 10	0 – 20	mm/jam
13	PPT	12 – 18	12 – 18	Detik
14	APTT	27 – 42	27 – 42	Detik

15	Bleeding Time	1 – 8	1 – 8	Menit
16	Clotting Time	8 – 18	8 – 18	Menit
17	Coomb Test	Negative	Negative	Negative
18	Malaria	Negative	Negative	Negative
19	Gula Darah Puasa	< 100	< 100	mg/dl
20	Gula Darah 2jpp	< 200	< 200	mg/dl
21	Gula Darah Sesaat	< 200	< 200	mg/dl
22	HbA1c	< 6,5	< 6,5	%
23	Cholesterol Total	150 – 220	150 – 220	mg/dl
24	HDL Cholesterol	>45	> 45	mg/dl
25	LDL Cholesterol	< 150	< 150	mg/dl
26	Triglyserida	< 150	< 150	mg/dl
27	SGOT	8 – 33	8 – 33	U/L
28	SGPT	4 – 36	4 – 36	U/L
29	Bilirubin Total	0,1 – 1,20	0,1 – 1,20	mg/dl
30	Bilirubin Direck	< 0,20	< 0,20	mg/dl
31	Bilirubin Indireck	< 0,50	< 0,50	mg/dl
32	Total Protein	6,5 – 8,0	6,5 – 80	mg/dl
33	Albumin	3,5 – 5,2	3,5 – 5,2	mg/dl
34	Globulin	2,5 – 5,5	2,5 – 5,5	mg/dl
35	Ureum	10 – 50	10 – 50	mg/dl
36	BUN	5 – 23	5 – 23	mg/dl
37	Creatinin	0,7 – 1,30	0,6 – 1,10	mg/dl
38	Uric Acid	3,0 – 7,0	3,0 – 6,0	mg/dl
39	CKMB	7 – 25	7 – 25	uL
40	Troponin I	Neg Bila <0,10	Neg Bila <0,10	uL
41	Natrium	135 – 148	135 – 148	mmol/L
42	Kalium	3,5 – 5,5	3,5 – 5,5	Mmol/L
43	Chlorida	98 - 106	98 – 106	g/dl
44	Calsium	8,6 – 10,3	8,6 – 10,3	%
45	T4	60 - 100	60 – 100	FL
46	T3	0,85 – 2,02	0,85 – 2,02	Pg

47	TSHS	0,27 – 4,20	0,27 – 4,20	g/dl
48	Widal			
49	S.Thypi O	Negatip	Negatip	-
50	S.Thypi H	Negatip	Negatip	-
51	S.O Parathypi A	Negatip	Negatip	-
52	S.O Parathypi B	Negatip	Negatip	-
53	IgG Anti HAV	Negatip	Negatip	-
54	IgM Anti HAV	Negatip	Negatip	-
55	TB DOT	Negatip	Negatip	-
56	IgM Salmonella	Negatip	Negatip	-
57	Hbs Ag	Negatip	Negatip	-
58	Hbs Ab	Negatip	Negatip	-
59	Urine Lengkap			
	Warna	Kuning Muda / Tua	Kuning Muda / Tua	-
	Keadaan	Jernih	Jernih	-
	Leukosit	Negatip	Negatip	-
	Keton	Negatip	Negatip	-
	Nitrit	Negatip	Negatip	-
	Blood	Negatip	Negatip	-
	Bilirubin	Negatip	Negatip	-
	Protein	Negatip	Negatip	-
	Glukosa	Negatip	Negatip	-
	B.J	Negatip	Negatip	-
	pH	Negatip	Negatip	-
	Silinder	Negatip	Negatip	-
	Eritrosit	0 - 1	0 – 1	/LPB
	Leukosit	2 - 3	2 – 3	/LPB
	Epitel	Negatip	Negatip	-
	Kristal	Negatip	Negatip	-
	Bakteri	Negatip	Negatip	-
	Lain-Lain	Negatip	Negatip	-
60	Faeces Lengkap			
	Bentuk	Padat/Lembek	Padat/Lembek	-

	Warna	Kuning/Coklat	Kuning/Coklat	-
	Lendir	Negatif	Negatif	-
	Darah	Negatif	Negatif	-
	Leukosit	Negatif	Negatif	-
	Eritrosit	Negatif	Negatif	-
	Telur Cacing	Negatif	Negatif	-
	Amoeba	Negatif	Negatif	-
	Cacing Dewasa	Negatif	Negatif	-
	Lemak	Negatif	Negatif	-
	Larva	Negatif	Negatif	-
	Cysta	Negatif	Negatif	-
	Bakteri	Negatif	Negatif	-

5.4 Kerjasama Laboratorium Rujukan

1. Identifikasi Kebutuhan Pemeriksaan Rujukan
- a. Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) mengajukan permintaan pemeriksaan yang tidak tersedia di laboratorium rumah sakit.

b. Petugas laboratorium melakukan verifikasi bahwa pemeriksaan tersebut memang belum dapat dilakukan di laboratorium rumah sakit.

c. Kepala Instalasi Laboratorium atau Penanggung Jawab Laboratorium menentukan laboratorium rujukan yang sesuai.
2. Persiapan Kerjasama
- a. Manajemen rumah sakit melakukan seleksi laboratorium rujukan berdasarkan:

1) Legalitas dan izin operasional.

2) Status akreditasi.

3) Kompetensi dan ruang lingkup pemeriksaan.

4) Ketepatan waktu pelayanan.

5) Sistem pelaporan hasil pemeriksaan.

6) Jaminan mutu laboratorium

b. Rumah sakit dan laboratorium rujukan menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang memuat:

1) Ruang lingkup pemeriksaan.

2) Hak dan kewajiban para pihak.

3) Mekanisme pengiriman spesimen.

4) Waktu penyelesaian hasil (Turn Around Time/TAT).

5) Tarif pelayanan.

6) Kerahasiaan data pasien.

7) Mekanisme penyelesaian masalah.

8) Mutu kerjasama
3. Monitoring dan Evaluasi
- a. Monitoring

Kepala Instalasi Laboratorium melakukan monitoring terhadap

1) Jumlah pemeriksaan rujukan.

-
- 2) Ketepatan waktu hasil pemeriksaan.
 - 3) Kesesuaian pengiriman spesimen.
 - 4) Kelengkapan dokumentasi.
 - 5) Pelaporan nilai kritis
- b. Evaluasi
- Evaluasi dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap tahun meliputi:
- 1) Kepatuhan terhadap PKS.
 - 2) Kinerja laboratorium rujukan.
 - 3) Ketepatan Turn Around Time (TAT).
 - 4) Mutu hasil pemeriksaan.
 - 5) Kejadian spesimen ditola
- c. Tindak lanjut
- Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar:
- 1) Perpanjangan atau penghentian kerja sama.
 - 2) Perbaikan proses pelayanan rujukan.
 - 3) Penyusunan rencana peningkatan mutu pelayanan laboratorium¹

BAB VI LOGISTIK

6.1 Perencanaan Kebutuhan

1. Identifikasi kebutuhan
 - a. Petugas logistik laboratorium melakukan inventarisasi seluruh kebutuhan logistik.
 - b. Mengidentifikasi:
 - 1) Jenis pemeriksaan yang tersedia.
 - 2) Volume pemeriksaan.
 - 3) Reagensia dan bahan pendukung yang diperlukan.
 - 4) Program pengembangan layanan laboratorium.
 - c. Menentukan daftar reagensia esensial yang wajib tersedia untuk mendukung pelayanan pasien
2. Pengumpulan data
Petugas mengumpulkan data:
 - a. Pemakaian 6–12 bulan sebelumnya.
 - b. Jumlah pemeriksaan laboratorium.
 - c. Stok tersedia.
 - d. Barang dalam proses pemesanan.
 - e. Barang rusak atau kedaluwarsa.
 - f. Lead time pengadaan.
 - g. Safety stock dan buffer stock
3. Perhitungan kebutuhan
Perhitungan mempertimbangkan:
 - a. Tren peningkatan jumlah pasien.
 - b. Penambahan jenis pemeriksaan.
 - c. Program mutu laboratorium.
 - d. Kebutuhan pelayanan 24 jam
4. Penyusunan rencana kebutuhan barang
Petugas menyusun rencana kebutuhan barang yang memuat:
 - a. Nama barang.
 - b. Satuan.
 - c. Stok tersedia.
 - d. Rata-rata pemakaian.
 - e. Jumlah kebutuhan.
 - f. Estimasi harga.
 - g. Total anggaran
5. Verifikasi dan persetujuan
 - a. Kepala Instalasi Laboratorium melakukan verifikasi.
 - b. RKB diajukan kepada Direktur atau pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan.
 - c. Dokumen yang telah disetujui menjadi dasar proses pengadaan.

6.2 Pengadaan

1. Pengajuan permintaan pengadaan
 - a. Petugas logistik mengajukan permintaan pengadaan berdasarkan RKB yang telah disetujui.
 - b. Permintaan dilengkapi dengan:
 - 1) Formulir permintaan barang.

- 2) Data stok.
 - 3) Justifikasi kebutuhan
2. Verifikasi permintaan

Unit pengadaan melakukan verifikasi terhadap:

 - a. Kesesuaian kebutuhan.
 - b. Ketersediaan anggaran.
 - c. Spesifikasi barang.
 - d. Prioritas pelayanan
3. Pemesanan barang
 - a. Unit pengadaan menerbitkan surat pesanan (Purchase Order/PO).
 - b. PO memuat:
 - 1) Nama barang.
 - 2) Jumlah barang.
 - 3) Spesifikasi.
 - 4) Harga.
 - 5) Jadwal pengiriman.
 - c. Salinan PO disampaikan kepada laboratorium sebagai dokumen kontrol.
4. Monitoring pengadaan
 - a. Status pesanan.
 - b. Jadwal pengiriman.
 - c. Kesesuaian barang yang akan diterima.
 - d. Potensi keterlambatan pengiriman.

Tabel 6.2.1 Syarat Pengadaan Barang

No	Barang	Lampiran
1	Sediaan Farmasi	Nomor Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
2	Alat Kesehatan	Nomor Izin Edar dari Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan <i>Certificate of Origin</i>
3	Bahan Medis Habis Pakai	Nomor Izin Edar dari Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
4	B3	<i>Material Safety Data Sheet (MSDS)</i> ” atau Lembar Data Pengaman (LDP)

6.3 Penerimaan

1. Penerimaan barang
 - a. Barang diterima oleh petugas yang ditunjuk.
 - b. Penerimaan dilakukan bersama petugas gudang atau unit pengadaan sesuai kebijakan rumah sakit.
2. Pemeriksaan administratif
 - a. Surat jalan.
 - b. Faktur.
 - c. Purchase Order (PO).
 - d. Sertifikat atau dokumen pendukung bila diperlukan
3. Pemeriksaan fisik barang
 - a. Nama barang.
 - b. Jumlah barang.
 - c. Nomor batch/lot.

- d. Kondisi kemasan.
- e. Tanggal kedaluwarsa.
- f. Kesesuaian spesifikasi dengan pesanan.
- g. Kondisi rantai dingin (cold chain) bila diperlukan
- 4. Verifikasi kualitas
Untuk reagensia dan bahan laboratorium dilakukan pemeriksaan:
 - a. Integritas kemasan.
 - b. Tidak terdapat kebocoran atau kerusakan.
 - c. Masa kedaluwarsa masih memenuhi ketentuan rumah sakit.
 - d. Kondisi penyimpanan selama pengiriman sesuai persyaratan pabrik.
- 5. Penolakan barang
 - a. Untuk reagensia dan bahan laboratorium dilakukan pemeriksaan:
 - 1) Tidak sesuai pesanan.
 - 2) Rusak.
 - 3) Kedaluwarsa atau mendekati kedaluwarsa sesuai ketentuan rumah sakit.
 - 4) Jumlah tidak sesuai.
 - 5) Tidak memenuhi spesifikasi.
 - b. Petugas membuat berita acara penolakan dan melaporkan kepada unit pengadaan
- 6. Pencatatan barang
 - a. Barang yang diterima dicatat pada:
 - 1) Buku penerimaan barang.
 - 2) Kartu stok.
 - 3) Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
 - b. Data yang dicatat:
 - 1) Nama barang.
 - 2) Nomor batch/lot.
 - 3) Jumlah.
 - 4) Tanggal penerimaan.
 - 5) Tanggal kedaluwarsa.
 - 6) Nama pemasok.

6.4 Penyimpanan

- 1. Penerimaan ke Area Penyimpanan
 - a. Petugas menerima logistik yang telah lolos pemeriksaan penerimaan.
 - b. Petugas mencatat barang ke dalam kartu stok dan/atau SIMRS.
 - c. Setiap barang diberi identifikasi berupa:
 - 1) Nama barang.
 - 2) Nomor batch/lot.
 - 3) Tanggal penerimaan.
 - 4) Tanggal kedaluwarsa.
 - 5) Kondisi penyimpanan
- 2. Penataan Penyimpanan
 - a. Logistik disimpan sesuai karakteristik dan persyaratan pabrik.
 - b. Penyimpanan memperhatikan:
 - 1) Suhu.
 - 2) Kelembaban.
 - 3) Sirkulasi udara.
 - 4) Pencahayaan.
 - 5) Keamanan.
 - c. Reagen yang memerlukan suhu khusus disimpan pada:
 - 1) Suhu ruang (15–25°C).

- 2) Lemari pendingin (2–8°C).
 - 3) Freezer sesuai ketentuan produsen
3. Pengaturan Sistem Penyimpanan
 - a. Diterapkan sistem:
 - 1) FIFO (*First In First Out*).
 - 2) FEFO (*First Expired First Out*).
 - b. Barang yang masa kedaluwarsanya lebih dekat ditempatkan di bagian depan agar digunakan terlebih dahulu
4. Penyimpanan Bahan Berbahaya
 - a. Bahan kimia berbahaya diberi label khusus.
 - b. Bahan yang tidak kompatibel (incompatible) disimpan terpisah.
 - c. Bahan mudah terbakar disimpan pada tempat yang aman dan sesuai ketentuan K3.

6.5 Distribusi

1. Permintaan barang
 - a. Unit kerja atau petugas laboratorium mengajukan permintaan logistik menggunakan formulir permintaan barang atau SIMRS.
 - b. Permintaan diverifikasi oleh Kepala Ruang/Kepala Instalasi Laboratorium.
2. Penyiapan barang
 - a. Petugas gudang menyiapkan barang sesuai permintaan.
 - b. Pengeluaran barang menggunakan prinsip:
 - 1) FIFO.
 - 2) FEFO.
 - c. Petugas memastikan barang yang diserahkan masih dalam kondisi baik dan belum kedaluwarsa.
3. Penyerahan barang
 - a. Barang diserahkan kepada petugas penerima.
 - b. Petugas penerima memeriksa:
 - 1) Jenis barang.
 - 2) Jumlah barang.
 - 3) Nomor batch (bila diperlukan).
 - 4) Tanggal kedaluwarsa.
 - c. Dilakukan pencatatan dan tanda tangan serah terima

6.6 Penggunaan

1. Logistik digunakan sesuai petunjuk penggunaan pabrik dan SOP laboratorium.
2. Penggunaan dicatat dalam formulir pemakaian atau SIMRS.
3. Setiap penggunaan harus memperhatikan prinsip:
 - 1) Tepat jenis.
 - 2) Tepat jumlah.
 - 3) Tepat metode.
 - 4) Tepat penyimpanan setelah digunakan.

6.7 Pengendalian Persediaan

1. Pencatatan stok
 - a. Setiap penerimaan dan pengeluaran barang wajib dicatat.
 - b. Pencatatan dilakukan pada:
 - 1) Kartu stok.
 - 2) Sistem informasi logistik/SIMRS.
2. Penetapan stok minimum dan maksimum
 - a. Kepala Instalasi Laboratorium menetapkan:
 - 1) Stok minimum.

- 2) Stok maksimum.
 - 3) Buffer stock.
 - b. Penetapan berdasarkan:
 - 1) Rata-rata pemakaian.
 - 2) Lead time pengadaan.
 - 3) Jenis pelayanan laboratorium
- 3. Stock opname
 - a. Dilakukan stock opname minimal setiap bulan.
 - b. Dilakukan pencocokan antara:
 - 1) Stok fisik.
 - 2) Kartu stok.
 - 3) Data SIMRS.
 - c. Selisih stok dianalisis dan ditindaklanjuti.
- 4. Evaluasi Persediaan
Evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. Ketersediaan reagen esensial.
 - b. Kejadian stock out.
 - c. Barang rusak.
 - d. Barang kedaluwarsa.
 - e. Efisiensi penggunaan logistik

6.8 Pemantauan Masa Berlaku

- 1. Pemeriksaan berkala
 - a. Petugas melakukan pemeriksaan masa berlaku secara rutin:
 - 1) Harian untuk reagen yang sedang digunakan.
 - 2) Bulanan untuk seluruh persediaan.
 - b. Pemeriksaan dilakukan terhadap:
 - 1) Tanggal kedaluwarsa.
 - 2) Nomor batch.
 - 3) Kondisi fisik barang
- 2. Identifikasi barang mendekati kedaluwarsa
 - a. Barang dengan masa berlaku ≤ 6 bulan diberi tanda khusus.
 - b. Barang diprioritaskan untuk digunakan terlebih dahulu sesuai prinsip FEFO
- 3. Penanganan barang kedaluwarsa
 - a. Barang kedaluwarsa segera dipisahkan dari stok aktif.
 - b. Diberi label:
 - c. "KEDALUWARSA – TIDAK BOLEH DIGUNAKAN"
 - d. Dicatat dalam daftar barang kedaluwarsa.
 - e. Dilakukan pemusnahan sesuai prosedur pengelolaan limbah medis dan B3 rumah sakit
- 4. Pelaporan
 - a. Petugas membuat laporan berkala mengenai:
 - 1) Barang mendekati kedaluwarsa.
 - 2) Barang kedaluwarsa.
 - 3) Barang rusak.
 - 4) Persediaan kritis
 - b. Laporan disampaikan kepada Kepala Instalasi Laboratorium dan manajemen rumah sakit.

6.8 Kekosongan Reagen

Prosedur kekosongan reagen

1. Identifikasi kekosongan reagen
 - a. Monitoring stok
 - 1) Petugas laboratorium melakukan pemantauan stok setiap hari.
 - 2) Pemantauan dilakukan melalui:
 - a) Kartu stok.
 - b) Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
 - 3) Petugas memastikan stok tidak berada di bawah batas minimum yang telah ditetapkan.
 - b. Deteksi kekosongan
Kekosongan reagen dapat diketahui melalui:
 - 1) Stok habis.
 - 2) Stok tidak mencukupi kebutuhan pelayanan.
 - 3) Reagen rusak.
 - 4) Reagen kedaluwarsa.
 - 5) Keterlambatan pengadaan.
 - 6) Gangguan distribusi dari pemasok.
2. Pelaporan kekosongan reagen
 - a. Pelaporan internal
 - 1) Petugas laboratorium segera melaporkan kepada Kepala Instalasi Laboratorium.
 - 2) Kepala Instalasi Laboratorium melakukan verifikasi kondisi stok.
 - 3) Hasil verifikasi dicatat dalam formulir kejadian kekosongan reagen.
 - b. Pelaporan kepada manajemen
Apabila kekosongan berpotensi mengganggu pelayanan, Kepala Instalasi Laboratorium melaporkan kepada:
 - 1) Direktur Rumah Sakit.
 - 2) Unit Pengadaan.
 - 3) Komite Mutu (bila diperlukan)
3. Analisis dampak pelayanan
Kepala Instalasi Laboratorium melakukan analisis terhadap:
 - a. Jenis pemeriksaan yang terdampak.
 - b. Jumlah pasien yang berpotensi terdampak.
 - c. Tingkat urgensi pemeriksaan.
 - d. Kemungkinan penggunaan metode alternatif.
 - e. Ketersediaan laboratorium rujukan.
 - f. Hasil analisis didokumentasikan sebagai dasar pengambilan keputusan.
4. Tindakan penanganan kekosongan reagen
 - a. Optimalisasi stok internal
Petugas melakukan:
 - 1) Pemeriksaan seluruh stok yang tersedia.
 - 2) Redistribusi antar unit laboratorium bila memungkinkan.
 - 3) Prioritas penggunaan untuk pemeriksaan yang bersifat cito atau emergensi
 - b. Pengadaan darurat
 - 1) Kepala Instalasi Laboratorium mengajukan permintaan pengadaan segera kepada Unit Pengadaan.
 - 2) Unit Pengadaan melakukan proses pengadaan sesuai ketentuan rumah sakit.
 - 3) Pengadaan darurat diprioritaskan untuk pemeriksaan yang

berdampak langsung terhadap pelayanan pasien.

c. Penggunaan metode alternatif

Apabila tersedia dan telah tervalidasi:

- 1) Laboratorium dapat menggunakan metode pemeriksaan alternatif.
- 2) Penggunaan metode alternatif harus mendapatkan persetujuan Dokter Penanggung Jawab Laboratorium.
- 3) Perubahan metode dicatat dan diinformasikan kepada pengguna layanan

d. Rujukan pemeriksaan

- 1) Pemeriksaan dirujuk ke laboratorium rujukan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- 2) Pengiriman spesimen dilakukan sesuai prosedur laboratorium rujukan.
- 3) Pasien dan dokter pengirim diberikan informasi mengenai proses rujukan.

BAB VII

KESELAMATAN PASIEN

7.1 Keselamatan Pasien Pada Tahap Pra Analitik

Tahap pra-analitik merupakan tahap dengan risiko kesalahan tertinggi sehingga harus dilakukan pengendalian sebagai berikut:

1. Identifikasi pasien
 - a. Petugas wajib melakukan identifikasi menggunakan minimal dua identitas pasien, yaitu:
 - 1) Nama lengkap pasien.
 - 2) Tanggal lahir.
 - 3) Nomor rekam medis.
 - 4) Nomor identitas lainnya sesuai kebijakan rumah sakit
 - b. Sebelum pengambilan spesimen petugas wajib
 - 1) Menanyakan identitas pasien secara langsung apabila pasien sadar.
 - 2) Mencocokkan identitas dengan gelang pasien.
 - 3) Mencocokkan identitas dengan formulir permintaan pemeriksaan
2. Verifikasi permintaan pemeriksaan
Petugas memastikan:
 - a. Formulir pemeriksaan lengkap.
 - b. Pemeriksaan sesuai indikasi klinis.
 - c. Dokter peminta jelas.
 - d. Data pasien lengkap
3. Pengambilan spesimen
Pengambilan spesimen dilakukan sesuai SOP dengan memperhatikan:
 - a. Teknik aseptik.
 - b. Pemilihan wadah yang sesuai.
 - c. Volume spesimen yang cukup.
 - d. Waktu pengambilan yang tepat.
 - e. Keselamatan pasien selama prosedur.
4. Pelabelan
Spesimen dikirim menggunakan wadah yang aman dengan memperhatikan:
 - a. Suhu penyimpanan.
 - b. Waktu pengiriman.
 - c. Pencegahan kerusakan atau kontaminasi.

7.2 Keselamatan Pasien Pada Tahap Analitik

1. Verifikasi Spesimen
 - a. Petugas laboratorium memeriksa:
 - 1) Kesesuaian identitas.
 - 2) Jenis spesimen.
 - 3) Kondisi spesimen.
 - 4) Kecukupan volume spesimen
 - b. Spesimen yang tidak memenuhi syarat ditolak sesuai prosedur penolakan spesimen
2. Pengendalian Mutu Internal (PMI)
Dilakukan secara rutin untuk memastikan:
 - a. Kinerja alat.
 - b. Kinerja reagen.
 - c. Akurasi hasil pemeriksaan.

-
3. Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat
Semua alat laboratorium:
 - a. Dikontrol secara berkala.
 - b. Dikalibrasi sesuai jadwal.
 - c. Didokumentasikan.
 4. Kompetensi Petugas
Pemeriksaan laboratorium hanya dilakukan oleh:
 - a. Dokter Spesialis Patologi Klinik.
 - b. Dokter Penanggung Jawab Laboratorium.
 - c. ATLM yang memiliki STR aktif dan kompetensi sesuai bidangnya.

7.3 Keselamatan Pasien Pada Tahap Pasca Analitik

1. Verifikasi hasil
Sebelum hasil dikeluarkan dilakukan:
 - a. Validasi teknis oleh ATLM.
 - b. Validasi medis oleh dokter yang berwenang (jika diperlukan).
2. Pelaporan hasil
Hasil disampaikan secara:
 - a. Tepat pasien.
 - b. Tepat pemeriksaan.
 - c. Tepat waktu.
 - d. Menjaga kerahasiaan pasien
3. Pengelolaan nilai kritis
Apabila ditemukan nilai kritis:
 - a. Petugas melakukan verifikasi hasil.
 - b. Hasil dilaporkan segera kepada DPJP atau dokter jaga.
 - c. Dilakukan komunikasi efektif menggunakan metode Tulis-Baca Kembali (Read Back).
 - d. Waktu pelaporan dicatat.
 - e. Tindak lanjut klinis didokumentasikan dalam rekam medis

BAB VIII
KESELAMATAN KERJA

8.1 Identifikasi dan Bahaya Kerja

- 1. Identifikasi bahaya
Kepala Instalasi Laboratorium bersama Tim K3 Rumah Sakit melakukan identifikasi risiko yang meliputi:
 - a. Bahaya biologis
 - 1) Darah dan cairan tubuh.
 - 2) Mikroorganisme patogen.
 - 3) Spesimen infeksius.
 - 4) Limbah infeksius.
 - b. Bahaya kimia
 - 1) Asam kuat.
 - 2) Basa kuat.
 - 3) Pelarut organik.
 - 4) Reagen toksik.
 - 5) Reagen korosif
 - c. Bahaya fisik
 - 1) Pecahan kaca.
 - 2) Jarum suntik.
 - 3) Sentrifus.
 - 4) Kebisingan.
 - 5) Suhu ekstrem
 - d. Bahaya ergonomi
 - 1) Posisi kerja yang tidak ergonomis.
 - 2) Gerakan berulang.
 - 3) Pengangkatan beban.
 - e. Bahaya listrik dan kebakaran
 - 1) Korsleting listrik.
 - 2) Alat laboratorium listrik.
 - 3) Bahan mudah terbakar
- 2. Penilaian risiko
Dilakukan secara berkala dengan menentukan:
 - a. Tingkat kemungkinan kejadian.
 - b. Tingkat dampak.
 - c. Prioritas pengendalian risiko

8.2 Penggunaan Alat Pelindung Diri

- 1. Penggunaan APD Wajib
Petugas wajib menggunakan APD sesuai risiko pekerjaan
Tabel 8.2.1 APD Wajib Petugas Laboratorium

No	Kegiatan	APD
1	Pemeriksaan rutin	Jas lab, masker, sarung tangan
2	Pengambilan darah	Jas lab, masker, sarung tangan
3	Penanganan bahan kimia	Jas lab, sarung tangan, pelindung mata
4	Penanganan tumpahan	APD lengkap sesuai risiko
5	Pengelolaan limbah	Sarung tangan, masker, apron

- 2. Ketentuan APD
 - a. APD harus tersedia dan mudah diakses.
 - b. APD diperiksa secara berkala.

- c. APD yang rusak harus segera diganti.
- d. Petugas dilarang bekerja tanpa APD sesuai risiko

8.3 Keselamatan Biologis (*Biosafety*)

1. Pengelolan spesimen
 - a. Semua spesimen dianggap berpotensi infeksius.
 - b. Spesimen diberi label biohazard bila diperlukan.
 - c. Transportasi spesimen menggunakan wadah tertutup
2. Pencegahan Pajanan
 - a. Tidak makan, minum, atau merokok di laboratorium.
 - b. Tidak melakukan pipet dengan mulut.
 - c. Melakukan kebersihan tangan sebelum dan sesudah bekerja.
 - d. Menghindari kontak langsung dengan spesimen
3. Penggunaan biosafety cabinet

Biosafety Cabinet digunakan untuk:

 - a. Pemeriksaan mikrobiologi tertentu.
 - b. Penanganan bahan infeksius berisiko tinggi.
 - c. Proses yang menghasilkan aerosol.

8.4 Keselamatan Kimia

1. Penyimpanan Bahan Kimia
 - a. Bahan kimia disimpan sesuai karakteristiknya.
 - b. Bahan yang tidak kompatibel disimpan terpisah.
 - c. Setiap bahan memiliki Label dan Lembar Data Keselamatan (SDS/MSDS).
2. Penggunaan Bahan Kimia

Petugas wajib:

 - a. Membaca petunjuk penggunaan.
 - b. Menggunakan APD sesuai risiko.
 - c. Menggunakan bahan sesuai kebutuhan.
3. Penanganan Paparan Kimia

Apabila terjadi kontak bahan kimia:

Pada Kulit

 - a. Bilas dengan air mengalir minimal 15 menit.
 - b. Laporkan kepada atasan.

Pada Mata

 - a. Gunakan eyewash station.
 - b. Bilas minimal 15 menit.
 - c. Segera dirujuk untuk pemeriksaan medis

8.5 Keselamatan Peralatan dan Listrik

1. Pemeriksaan Peralatan
 - a. Semua alat diperiksa sebelum digunakan.
 - b. Dilakukan pemeliharaan preventif dan kalibrasi berkala.
 - c. Alat rusak diberi label
2. Keselamatan Listrik
 - a. Stop kontak tidak boleh melebihi kapasitas.
 - b. Kabel yang rusak harus segera diganti.
 - c. Peralatan listrik harus memiliki grounding yang baik.
 - d. Petugas tidak diperbolehkan memperbaiki alat listrik tanpa kewenangan.

8.6 Keselamatan Kebakaran

1. Pencegahan Kebakaran
 - a. Tidak menyimpan bahan mudah terbakar dekat sumber panas.
 - b. Jalur evakuasi harus bebas hambatan.
 - c. APAR harus tersedia dan mudah dijangkau.
2. Tindakan Saat Kebakaran
Petugas melakukan:
 - a. Aktivasi alarm kebakaran.
 - b. Penggunaan APAR apabila aman dilakukan.
 - c. Evakuasi sesuai jalur evakuasi.
 - d. Pelaporan kepada Tim K3RS dan keamanan rumah sakit.

8.7 Penanganan Tumpahan

1. Tumpahan Bahan Infeksius
 - a. Pasang tanda peringatan.
 - b. Gunakan APD lengkap.
 - c. Tutup tumpahan dengan tisu atau absorbent.
 - d. Tuangkan disinfektan sesuai ketentuan.
 - e. Diamkan sesuai waktu kontak.
 - f. Bersihkan area.
 - g. Buang limbah ke wadah infeksius.
2. Tumpahan Bahan Kimia
 - a. Identifikasi jenis bahan.
 - b. Gunakan spill kit.
 - c. Ikuti petunjuk SDS/MSDS.
 - d. Ventilasi area bila diperlukan.
 - e. Laporkan kejadian kepada atasan

8.8 Penanganan Paparan dan Kecelakaan Kerja

1. Luka Tusuk Jarum
 - a. Jangan memijat luka.
 - b. Cuci dengan air mengalir dan sabun.
 - c. Laporkan kepada atasan.
 - d. Isi formulir insiden K3.
 - e. Lakukan evaluasi medis dan tindak lanjut sesuai program PEP rumah sakit.
2. Paparan Darah atau Cairan Tubuh
 - a. Bilas area yang terpapar.
 - b. Segera laporkan.
 - c. Dilakukan penilaian risiko.
 - d. Mendapatkan pemeriksaan dan tindak lanjut medis

BAB IX

PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu laboratorium Rumag Sakit Prima Husada adalah keseluruhan proses semua tindakan yang di lakukan untuk menjamin ketepatan dan ketelitian hasil pemeriksaan laboratorium, kegiatan pengendalian mutu agar mencapai layanan prima meliputi :

9.1 Pemantapan Mutu Internal (PMI)

Pemantapan Mutu Internal (PMI) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas laboratorium Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo untuk menjamin mutu pemeriksaan agar dapat mencapai layanan prima dengan mencegah terjadinya kesalahan dan mendeteksi sedini mungkin bila terjadi kesalahan, contoh yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahan validasi tes yang digunakan untuk tes akurasi, presisi, hasil rentang nilai dan koreksi cepat apabila ada kekurangannya dilakukan oleh analis supervisi. pemakaian reagensia harus mempunyai keunggulan sebagai berikut:

1. Validasi test yang di gunakan untuk tes akurasi ,yang di kerjakan oleh analis pelaksana, presisi dan hasil nilai dilaporkan dengan pencatatan hasil .
2. Suveilans hasil pemeriksaan di lakukan oleh analis supervise.
3. Uji tes Reagensia dilakukan pada waktu pertama kali datang dan dilakukan oleh analis pelaksana.
4. Koreksi kekurangan hasil laboratorium secara cepat dilakukan oleh supervii laboratorium.
5. Dokumentasi hasil pemriksaan laboratorium di lakukan oleh administrasi laboratorium, tidakan koreksi di lakukan oleh supervis analis. Untuk dokumentasi hasil dilakukan pengarsipan balnko permintaan dengan Hard Copy dan soft copy hasil laporan kegiatan.

9.2 Pemantapan Mutu Eksternal (PME)

1. Pelaksanaan PME
 - a. Laboratorium mengikuti program PME yang diakui Kementerian Kesehatan.
 - b. Sampel PME diperiksa sesuai prosedur rutin.
 - c. Hasil PME dikirim kepada penyelenggara.
 - d. Laboratorium melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh.
2. Tindak Lanjut PME

Apabila hasil tidak memuaskan:

 - a. Dilakukan analisis akar masalah.
 - b. Dilakukan tindakan korektif.
 - c. Dilakukan evaluasi efektivitas perbaikan.
 - d. Seluruh kegiatan didokumentasikan

9.3 Pelaporan Dan Penanganan Ketidaksesuaian, Penyimpanan Hasil, KTD dan Insiden Laboratorium.

1. Setiap kejadian yang mencakup:
 - a. Ketidaksesuaian proses atau hasil,
 - b. Penyimpangan hasil pemeriksaan,
 - c. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)
 - d. Insiden keselamatan pasien
 - e. Potensi risiko yang dapat memengaruhi mutu pelayanan, wajib dikelola melalui sistem pelaporan insiden laboratorium.

-
2. Jenis Kejadian yang dilaporkan
 - a. Kesalahan identifikasi spesimen/pasien.
 - b. Hasil pemeriksaan tidak sesuai kondisi klinis (outlier tanpa penjelasan).
 - c. Keterlambatan hasil (TAT tidak terpenuhi).
 - d. Spesimen tertukar, hilang, atau rusak.
 - e. Kesalahan input atau validasi hasil.
 - f. Kegagalan alat atau reagen.
 - g. Insiden keselamatan kerja (tertusuk jarum, paparan biologis).
 3. Proses Pelaporan
 - a. Identifikasi kejadian
Ditemukan oleh petugas atau laporan unit lain.
 - b. Pelaporan segera
Mengisi formulir insiden atau sistem pelaporan internal.
 - c. Dokumentasi awal
Waktu kejadian, lokasi, kronologi singkat, pihak terkait.
 - d. Pelaporan ke penanggung jawab laboratorium
Kepala unit/koordinator mutu.
 4. Analisa Penyebab
Dilakukan untuk mencari akar masalah menggunakan metode seperti:
 - a. *Root Cause Analysis* (RCA)
 - b. Fishbone diagram (*man, method, machine, material, environment, measurement*)Fokus analisis:
 - a. Faktor manusia (human error)
 - b. Sistem/prosedur
 - c. Peralatan
 - d. Lingkungan kerja
 - e. Manajemen/logistic
 5. Tindakan Korektif Dan Preventif
 - a. Tindakan Korektif
Dilakukan untuk memperbaiki kejadian yang sudah terjadi:
 - 1) Perbaikan hasil atau pengulangan pemeriksaan.
 - 2) Koreksi data atau laporan.
 - 3) Perbaikan prosedur yang langsung bermasalah.
 - b. Tindakan Preventif
Dilakukan untuk mencegah kejadian berulang:
 - 1) Revisi SOP.
 - 2) Pelatihan ulang petugas.
 - 3) Kalibrasi alat.
 - 4) Penguatan sistem identifikasi spesimen.
 - 5) Perbaikan alur kerja.
 6. Dokumentasi
Semua proses harus dicatat dan disimpan, meliputi:
 - a. Formulir pelaporan insiden.
 - b. Hasil analisis RCA.
 - c. Bukti tindakan korektif dan preventif.
 - d. Evaluasi tindak lanjut.
 7. Monitoring Dan Evaluasi
 - a. Pemantauan efektivitas tindakan perbaikan.
 - b. Audit internal berkala.
 - c. Analisis tren insiden laboratorium.
 - d. Pelaporan ke komite mutu dan keselamatan pasien

BAB X

PENUTUP

Demikian Pedoman Pelayanan ini dibuat, supaya menjadi pedoman dalam semua kegiatan pelayanan laboratorium. Bila ada perubahan yang harus dilakukan untuk tujuan Keselamatan pasien dan peningkatan mutu, maka Pedoman ini dapat dirubah mengikuti standar yang ada dan yang diharuskan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 01 Desember 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



Heni Indra Wulandari, S. Kep.Ns.,M.Kep

